

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE **PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS** (PAPs)

DIRIGIDO A POBLACIÓN MIGRANTE,
SOLICITANTE DE REFUGIO Y REFUGIADA

PROYECTO:
"VENTANILLAS DE REFERENCIA LOCAL PARA EL APOYO MIGRATORIO"



"Este Proyecto está siendo financiado con fondos del Gobierno de Estados Unidos".

Publicado por: FUNPADEM

Elaborado por:

Sofía Álvarez Calvo

Isabel Sáenz Gutiérrez

María José Zamora Da Costa

Revisión técnica:

Dayana Espinosa Patti, Técnica

Sergio Guillén, Director de Proyecto

*Sarah Castrillo, Coordinadora de
Programas*

Diseño:

Jeffrey Muñoz

ISBN: 978-9930-547-09-0

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	2
¿QUÉ ES UNA CRISIS PSICOLÓGICA?	3
¿QUÉ SON LOS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS?	5
¿CUÁL ES EL TIEMPO O MARGEN DE ACCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PAPS?	7
APLICACIÓN DE PAPS EN POBLACIÓN MIGRANTE	7
¿QUIÉNES PUEDEN APLICAR LOS PAS?	8
¿DÓNDE Y BAJO QUÉ CONDICIONES PUEDEN BRINDARSE?	9
¿PARA QUÉ SIRVEN?	11
PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN	12
FASES DE APLICACIÓN	16
RECOMENDACIONES SEGÚN GRUPOS ETARIOS	30
ASPECTOS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA	31
PONIENDO EN PRÁCTICA LO APRENDIDO	33
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	38
ANEXOS	37
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	62

INTRODUCCIÓN

El presente documento surge en el marco del Proyecto “Ventanillas de Referencia Local para el Apoyo Migratorio” desarrollado por FUNPADEM en apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América.

A continuación, se presenta el Manual de Primeros Auxilios Psicológicos (PAPs), en el cual se mencionan los pasos a seguir para la implementación de este apoyo que puede abordarse en diversos contextos y poblaciones. En este caso específico, la propuesta se aterriza a personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas que llegan a Costa Rica tras diversas situaciones, las cuales les obliga a realizar desplazamientos forzados.

A lo largo del manual, se detallan los aspectos relevantes para que actores clave de las comunidades puedan orientar, asesorar y escuchar a personas que son víctimas de algún evento traumático como es el caso de: víctimas de tortura, familias o personas que huyen de conflictos armados, persecución política, menores de edad no acompañados, viajes con condiciones inseguras o violentas, violencia sexual, entre otros eventos. La aplicación de los PAPs, permite prevenir que se desarrollen condiciones propias de un evento traumático que no es abordado, como es el caso de estrés postraumático, duelo migratorio, depresión, estrés agudo y otras consecuencias psicológicas; por lo que más adelante se describirán las pautas a seguir para aplicarlos de la mejor manera.

Ante las situaciones mencionadas anteriormente, se ha identificado el interés dentro de Instituciones y actores clave de las comunidades de acogida que tienen la posibilidad de capacitarse para ayudar a quienes han experimentado situaciones traumáticas en sus procesos de huida o viaje. Es por ello que el presente documento pretende brindar insumos para las herramientas de manera práctica, con respeto a la diversidad y los Derechos Humanos, a personas que recién llegan al país o que han sufrido algún evento traumático posterior a su llegada.

Por tal razón, se describen los aspectos que pueden propiciar en las personas la capacidad de ser resilientes, es decir, recuperarse de las situaciones traumáticas o estresantes que han enfrentado sin secuelas que repercutan en su salud mental y bienestar integral.

¿QUÉ ES UNA CRISIS PSICOLÓGICA?

Antes de iniciar el abordaje sobre el manejo de una crisis psicológica en una persona o un grupo específico por medio de la herramienta de primeros auxilios psicológicos, es necesario definir lo que se entiende por crisis a este nivel para así realizar una aproximación adecuada para comprender los diversos contextos a los que se puede enfrentar:

Una crisis psicológica es un estado en el cual las herramientas y mecanismos psíquicos que solían ser utilizadas por los sujetos para manejar y resolver distintas situaciones no funcionan. Encontramos entonces la imposibilidad de funcionar u operar de la misma forma que en otras situaciones (...) La tensión psíquica es tal que el sujeto se ve sobrepasado por la situación. (...) Es una irrupción, un corte, un cambio, una transformación que no estaba contemplada, que rompe con todo lo conocido. En este ámbito el evento o trauma es tan fuerte que el sujeto es incapaz de ponerlo en palabras, significarlo. Es por eso que se dice que las herramientas o mecanismos que utilizaba siempre no funcionan. La crisis debe de tener un estado de transitoriedad. Es crisis porque es un estado que no ha sido normalizado por los sujetos. Sin embargo,

en muchas ocasiones este estado se eterniza y se termina naturalizando, lo cual ya no es una crisis, sino un nuevo estado, un nuevo orden. (Villalobos, 2011, p.18)

Sumado a lo anterior, según La Guía de Atención a Pacientes en Crisis Emocional de la Universidad Industrial de Santander (2014) en una crisis: “Se pierde temporalmente la capacidad de dar una respuesta efectiva y ajustada al problema porque fallan los mecanismos habituales de afrontamiento y existe incapacidad para manejar las situaciones y/o dar soluciones a los problemas” (p.1). Siguiendo esta línea, puede surgir la interrogante de entender ¿qué origina una crisis psicológica?, en la guía mencionada, se expone en síntesis que pueden existir muchos factores, así como eventos distintos que ocasionen crisis, los cuales pueden producir distintas reacciones en las personas por lo cual es posible esperar reacciones diferentes según las herramientas de afrontamiento de cada una y su capacidad de desarrollar resiliencia.

Por último, Deza (2007) menciona que un individuo o las personas en crisis: “Enfrentan un problema ante el cual sus recursos de adaptación, así como mecanismos de defensa usuales no funcionan satisfactoriamente. El problema rebasa sus capacidades de resolución y se encuentra en franco desequilibrio. Como resultado de todo esto la persona experimenta una mayor tensión y ansiedad, lo cual la inhabilita aún más para encontrar una solución” (p.38).

Ante lo expuesto, cabe resaltar la importancia de la aplicación de los Primeros Auxilios Psicológicos (PAPs) en cualquier persona, grupo o comunidades, ya que no todas las personas cuentan con las herramientas para hacer frente a una crisis, lo cual puede contribuir el desarrollo de algunas sintomatologías que pueden estar asociadas a una psicopatología o implicación de salud mental que puede prevenirse con el entrenamiento adecuado de los equipos intersectoriales comunitarios.

Sin embargo, antes de iniciar el abordaje de los temas asociados a los PAPs, es necesario conceptualizar los siguientes términos asociados a condiciones de salud mental que forman parte de algunas de las repercusiones psicológicas que queremos prevenir:

CUADRO 1. CONDICIONES PSICOSOCIALES MÁS COMUNES A DESARROLLAR POSTERIOR A UNA CRISIS

Condición	Concepto	Síntomas
Trastorno por Estrés Agudo (TEA)	Es un trastorno transitorio con gravedad importante. Surge como respuesta a un estrés excepcional, el cual puede presentarse durante horas o días, e incluso hasta las 6 primeras semanas después del suceso.	• Hiper alerta: Insomnio, Sobresaltos, hipervigilancia, irritabilidad y Síntomas físicos de ansiedad. • Reexperimentación: Pensamientos intrusivos, Flashbacks y Pesadillas recurrentes. • Evitación: Esfuerzos para evitar acciones, personas o lugares, Embotamiento afectivo intenso e Incapacidad para continuar con la vida habitual. • Síntomas Disociativos: Sensación de desapego, Reducción de la conciencia del entorno, Despersonalización y Amnesia disociativa. • Deterioro de la Capacidad Funcional: Malestar o sufrimiento, Interferencia en el funcionamiento normal, disminución de la capacidad para el desempeño de las actividades habituales.

Trastorno por Estrés Post Traumático (TEPT)	Es un Trastorno agudo o crónico, el cual es muy grave, ya que puede surgir de un Trastorno de Estrés Agudo mal gestionado. Es la respuesta a un estrés excepcional debido a un hecho traumático, la cual puede abordarse y trabajarse con ayuda profesional únicamente. Parte de su identificación parte de la persistencia de los síntomas en un periodo superior al mes de ocurrido el evento traumático.	• Hiperalerta: Dificultades para conciliar el sueño, dificultad de concentración, irritabilidad y/o episodios de cólera e Hipervigilancia. • Re-experimentación: Recuerdos repetitivos e intrusivos (imágenes o pensamientos), Flashbacks, pesadillas recurrentes, malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos relacionados con el suceso, respuestas fisiológicas consecutivas a estos estímulos. • Evitación: Esfuerzos para evitar acciones, personas o lugares, embotamiento afectivo intenso, imposibilidad para recordar ciertos aspectos del suceso, descenso de las actividades cotidianas y de las relaciones sociales, dificultades para planificar e imaginar el futuro.
Depresión	Existencia de serie de síntomas que afectan directamente el plano emocional. Sin embargo, su presencia no indica directamente un trastorno. La causa más común de depresión es la pérdida de un familiar, amistad, pareja o hijo/a, ser víctima de tortura o violación, entre otros; sin embargo, también se puede presentar por pérdida de posesiones materiales, trabajo, posición social, etc. No todos los cuadros son iguales	• Tristeza Agobiante y Aflicción profunda. • Desesperanza. • Pensamientos suicidas o de infligirse daño a sí mismos. • Propensión al llanto o/y preocupación constante • Ansiedad y tensión. • Falta de alegría e ilusión por vivir, incluso perspectiva sombría del futuro. • Falta de energía, cansarse fácilmente. • Síntomas orgánicos como: dolores de cabeza que no desaparecen, alteraciones del sueño, pérdida o subida de peso, desinterés por las relaciones sexuales. • Dificultad para centrar la atención o recordar. • Sentirse “malo”, indigno o menos respetado por los demás.

Fuente Elaboración propia a partir de: Curso Virtual Primeros Auxilios Psicológicos Universidad Autónoma de Barcelona (2015), Página oficial U.S Department of Veterans Affairs (2020) y Villalobos (2011).

Como se menciona en Inter Agency Standing Committee (IASC) Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings (2007), en cualquier nivel de las emergencias incrementa el nivel de riesgo de amplificar problemas sociales preexistentes en cuanto a injusticia e inequidad. Por ende, las crisis van a facilitar la instalación de problemas psicológicos como consecuencia de no tener las herramientas o bien tener antecedentes de alguna índole. Es por ello que es crucial entender que, si bien se pueden aplicar los PAPs ante las crisis de diversas índoles, en especial con la población migrante, si se visualizan síntomas relatados anteriormente, es necesario remitir a algún profesional de salud mental para brindar atención inmediata para poder restablecer el equilibrio emocional.

Gonçalves (2017) aporta que, en los enfoques de diversas teorías y disciplinas, así como de distintos métodos de tratamiento, se reconoce que el trauma tiene impacto en diversas funciones, lo que se manifiesta en alteraciones afectivas, cognitivas, motrices, de la memoria, en las relaciones sociales, así como en el desarrollo evolutivo. Así mismo deja claro que los traumas psicológicos forman parte de nuestra vida cotidiana, desde que se nace hasta distintos hechos cotidianos que dejan marca en las personas a lo largo de la vida.

¿QUÉ SON LOS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS?

Existen distintos abordajes y aportes que se han construido a partir de una acumulación progresiva de conocimientos entorno a la primera atención posterior a una crisis, la cual ha tenido distintas denominaciones que permiten entender en qué consiste la herramienta y sus principales aportes. Es por ello, que a continuación se visualizarán aspectos o características destacadas para la comprensión de su utilidad en el ámbito comunitario con población migrante con algún grado de vulnerabilidad.

Primeramente, para iniciar el abordaje teórico sobre los Primeros Auxilios Psicológicos (PAPs), se pueden conceptualizar como:

Un enfoque modular basado en la evidencia y cuyo objetivo es ayudar a niños, adolescentes, adultos y familias a afrontar las consecuencias inmediatas de desastres o eventos traumáticos. Están diseñados para reducir a corto y largo plazo la angustia inicial producida por eventos traumáticos y para promover el funcionamiento adaptativo y las habilidades de afrontamiento. Los Primeros Auxilios Psicológicos no suponen que todos los sobrevivientes desarrollarán problemas de salud mental severos o dificultades para recuperarse a largo plazo (National Child Traumatic Stress Network, 2006, p.5).

Por otro lado, Cortés y Figueroa (2015) proponen que los PAPs están definidos como: Una técnica de apoyo humanitario para personas que se encuentran en situación de crisis (ej. crisis humanitarias, accidente de tránsito, noticia de familiar gravemente enfermo, incendio, desastre natural, asalto, etc.), que tiene como objetivo recuperar el equilibrio emocional y prevenir el desarrollo de secuelas psicológicas (p.6)

Por otra parte, la primera ayuda psicológica para la Organización Panamericana de la Salud (2006) es la intervención que se lleva a cabo en una persona en crisis, por parte de un miembro de un equipo de respuesta o por una persona de la comunidad para aliviar las tensiones creadas por un suceso que amenaza la vida o la seguridad del individuo o su entorno; se brinda en la misma escena de los acontecimientos (p.125)

La meta principal de los primeros auxilios psicológicos es reestablecer el enfrentamiento inmediato, por eso, según Caplan (1964) y retomando parte de lo mencionado, las crisis vitales se caracterizan por un colapso de las capacidades de solución de problemas y enfrentamiento que antes eran adecuadas. Para la persona en crisis, el punto crucial del asunto es que ella, de modo simple, se siente incapaz de tratar con las circunstancias abrumadoras que confronta en ese momento. Es por ello que con la técnica se orienta a la persona para que, de manera sencilla, pueda estabilizar sus emociones para poder actuar ante el nuevo contexto que se le presenta.

Desde todos los aportes mencionados anteriormente, se puede retomar como puntos clave que los PAPs poseen como enfoque principal ayudar a quienes se han visto afectados, directa o indirectamente, por eventos potencialmente traumáticos y diversos tipos de crisis, los cuales podemos imaginar o ejemplificar desde las vivencias cotidianas, éstos podrían ser:

	Actos violentos (robos, asaltos, tortura, abuso sexual)
	Conflictos armados, violencia basada en género, intentos de homicidio, secuestros).
	Persecución-huida por diversos motivos.
	Urgencias médicas.
	Accidentes de diversos tipos.
	Comunicación de noticias difíciles (fallecimiento o enfermedades graves).
	Emergencias.
	Desastres, entre muchos otros.

Lo que se pretende principalmente es estabilizar, aliviar o calmar a la persona para que pueda instaurar mecanismos para afrontar o adaptarse mejor a la situación que está viviendo o acaba de suceder.

No obstante, no se puede perder de vista el aporte de Slaikeu (1988) sobre reducir el papel de los primeros auxilios psicológicos para reducir el daño físico y proteger la vida ante las consecuencias que pueden ser desencadenados a raíz de la carga emocional que conlleva el experimentar una situación traumática. Desde esa perspectiva, el enfoque de los primeros auxilios psicológicos

Se dirige a la salvación de vidas y la prevención del daño físico durante las crisis. Es frecuente, de manera especial en una sociedad donde la violencia es, por mucho, una parte de la vida cotidiana, que algunas crisis conduzcan al daño físico (como golpear a los hijos o al cónyuge) o aun a la muerte (suicidio, homicidio). Una submeta determinante para los primeros auxilios psicológicos es, entonces, tomar medidas para hacer mínimas las posibilidades destructivas y desactivar la situación (p.114).

¿CUÁL ES EL TIEMPO O MARGEN DE ACCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PAPs?

Con base a los estudios de Hernández & Gutiérrez (2014), se acuerda que es necesario aplicar los PAPs lo antes posible, principalmente en la **fase de shock y adaptación**, es decir, durante las primeras 72 horas después de ocurrida la llegada de la persona al país, luego de algún percance asociado al viaje-huida o evento traumático en general. Cuando hay situaciones que impiden prestar la atención en dicho periodo, ésta puede brindarse dentro de las primeras 4 a 6 semanas, pero en este caso debe potenciarse instaurar la resiliencia en las personas afectadas, buscando opciones de apoyo humanitario, rutas de denuncias o acceso de apoyos específicos según necesidades y referencias a servicios disponibles en caso de ser necesario.

Según Álvarez (2015), si han pasado más de 6 semanas desde el evento traumático, se debe recurrir a otro tipo de técnicas de intervención psicológico basados en la psico-educación y la normalización. Sin embargo, para esto es necesario mapear las Organizaciones e Instituciones del país que pueden brindar dichos procesos.

Ante todo lo anterior, y desde la experiencia en atención humanitaria del equipo consultor, es importante mantener un seguimiento en cuanto a los tiempos de los sucesos traumáticos relatados por la persona y la sintomatología que comparten, ya que son insumos que pueden brindar las “pistas” necesarias para identificar si es necesaria o no la referencia de las personas a servicios especializados en salud mental.

APLICACIÓN DE PAPs EN POBLACIÓN MIGRANTE

El objetivo de los primeros auxilios psicológicos es equilibrar a la persona en sus emociones, por ende, devolverle tranquilidad, la capacidad de pensar en el contexto actual con un futuro en donde existen opciones para salir adelante a nivel individual y/o familiar para incorporarse en la sociedad.

Al ser la primera respuesta, por lo tanto, es de vital importancia la capacitación en la aplicación de esta metodología a las personas indicadas en los contextos comunitarios para abordar en este caso a población migrante de distintas categorías migratorias, las cuales han atravesado infinidad de situaciones para llegar al país receptor, en este caso Costa Rica.

Desde una perspectiva psicoanalítica, León y Grinberg (1984) mencionan que las migraciones como una experiencia traumática y de crisis en la que las situaciones externas influyen sustancialmente sobre las condiciones internas para afrontar el proceso de migración, pero en la que la personalidad previa del sujeto, sus características psicológicas predominantes y su momento vital determinarán su decisión de migrar o no, y la calidad de la migración que haga. Pueden ocurrir situaciones de violencia.

Es posible que las personas migrantes requieran los primeros auxilios psicológicos para procesar las emociones, producto de incidentes en el camino o para hacer frente a las ulteriores dificultades que conlleva la migración, por ejemplo: información y enlace con otros servicios, resolución de necesidades inmediatas como abrigo, comida, albergue, conexión con personas de apoyo como familiares o amigos, canalización con especialistas, entre otros. Es importante que quienes presten este servicio comprendan que no se debe forzar a las personas a recibir esta atención, sino estar disponibles para aquellos que deseen apoyo (OIM, 2018).

¿QUIÉNES PUEDEN APLICAR LOS PAPs?

Desde la denominada “Primera Ayuda Psicológica”, la Organización Panamericana de la Salud (2006) establece que es: “Una técnica sencilla y práctica; no es un procedimiento especializado, pero se requiere un entrenamiento básico para su aplicación. Por esta razón, se debe capacitar al personal que potencialmente podría intervenir en la primera respuesta (...) es importante trabajar en la preparación de los trabajadores de atención primaria en salud y de los equipos institucionales de respuesta y ayuda humanitaria” (p.127).

Por otro lado, según la Guía de Primeros Auxilios Psicológicos de National Child Traumatic Stress Network (2006), menciona que los Primeros Auxilios Psicológicos están diseñados para ser prestados por trabajadores de salud mental o personal que proporcione asistencia temprana a niños, familias y adultos afectados, como parte de un esfuerzo organizado de respuesta ante un desastre o crisis. Es decir, estos proveedores pueden formar parte de una variedad de equipos de respuesta de primera instancia.

Con base a lo anterior, se puede entender que los PAPs son una técnica que cualquier persona o equipo puede poner en práctica siempre y cuando cuenten con la información o el entrenamiento adecuado (tal como el presente documento y el taller facilitado). La técnica es sencilla y práctica; no es un procedimiento especializado, por lo cual con el entrenamiento se puede intervenir en la primera respuesta en situaciones de crisis o desastres (OPS, 2006).

Sumando a lo mencionado, Terlonge (2013) en el Manual de capacitación sobre primeros auxilios psicológicos para profesionales de la niñez de Safe for Children, hace referencia a que es importante identificar organizaciones socias, funcionarios clave según la población de abordaje y trabajadores sociales o de la salud, quienes pueden prestar primeros auxilios psicológicos para quienes requieren de su aplicación; incluso podrían aplicarlos con entrenamiento quienes llegan después de la crisis y pueden aportar en situaciones difíciles. Esto refuerza que para el caso de los CREDES, las funcionarias que los lideran, además de quienes fueron parte de los talleres asociados al tema, podrían ejercer una atención inicial para aliviar a las personas independientemente de su grupo etario para que puedan recibir no solo orientación legal o de trámites, sino garantizar su protección y bienestar psicosocial, habilitando un espacio de escucha y de validación de la experiencia para aliviar ciertos pensamientos o síntomas asociados a su procesos migratorio.

Aunque profesionales en salud mental pueden aplicar los PAPs, no es necesaria la formación profesional para ello. Sin embargo, es necesario comprender que si se identifica la limitación para abordar algún caso en el que se involucre una persona con alguna condición para la cual se considera que **no** se cuenta con capacitación suficiente, es relevante identificar las rutas de referencia adecuadas para que otras personas con experiencia y formación en la atención psicosocial, puedan brindar una mejor intervención. Asimismo, se debe aprender durante el proceso a identificar que si persisten ciertos síntomas posterior a un periodo de cuatro semanas tras la aplicación de los PAPs, lo mejor es que algún profesional de la salud mental realice una evaluación y atención de la persona, ya que podría estar sufriendo alguna condición para la cual no tenemos margen de acción como es el caso del síndrome de estrés post traumático u otras condiciones que pueden desarrollarse tras situaciones descritas anteriormente en el primero apartado.

Conforme a las consideraciones previamente indicadas, en el anexo final del documento, se adjunta un mapeo de Instituciones y Organizaciones que es necesario contemplar de manera inicial para brindar referencias según las necesidades de las personas abordadas en las comunidades. Dicho listado debe estar en constante actualización, debido al contexto cambiante, así como posible relevo de personas u Organizaciones con liderazgo. Ante el contexto actual, en donde Costa Rica se ha convertido en un país de acogida, es deseable actuar de manera coordinada y no con esfuerzos aislados que pueden generar confusiones en las personas afectadas.

¿DÓNDE Y BAJO QUÉ CONDICIONES PUEDEN BRINDARSE?

Los Primeros Auxilios Psicológicos (PAPs) se pueden aplicar según en cuestión de minutos u horas, en cualquier lugar a disposición en la comunidad, el cual debe ser lo más confortable, en una zona que proporcione seguridad a las personas, protección de su identidad de actores externos y con personal que tenga claros los principios de su aplicación (Álvarez, 2015).

Terlonge (2013) a grandes rasgos hace mención que la técnica se puede prestar en cualquier lugar seguro y acogedor, éstos pueden ser habilitados en espacios como: Centros educativos, albergues para migrante o personas refugiadas, albergues de emergencias naturales, Centros Hospitalarios o en donde pueda ser posible garantizar las condiciones mencionadas, así como permitir que la persona se encuentra tranquila y segura, esto para que sea más sencillo conversar y aliviar las emociones que se presentan tras el evento traumático

Otro aporte necesario de tomar en cuenta es abordado desde la Organización Mundial de la Salud (2012) en la Guía de Primera Ayuda Psicológica para trabajadores de campo, en donde se menciona que los PAPs pueden ofrecerse donde quiera que se esté, siempre y cuando sea seguro para poder hacerlo. Con frecuencia se da esta situación en lugares comunitarios, como la escena de un accidente, o lugares donde se atiende a las personas afectadas como centros de salud, albergues, centros de apoyo humanitario, entre otros según el contexto. Lo ideal sería proporcionar PAPs en un lugar donde exista cierta privacidad para hablar con la persona cuando se considere oportuno. Para personas expuestas a ciertos tipos de acontecimientos críticos, como violencia sexual, la privacidad es esencial para la confidencialidad y el respeto de la dignidad de la persona.

A continuación, se detallan algunas de las principales condiciones a tomar en cuenta para casos ideales (si se cuenta con los recursos para el acondicionamiento de espacios) o aspectos mínimos en los espacios de aplicación, los cuales se mencionan a continuación:

Tabla N°1. Condiciones para Brindar Primeros Auxilios Psicológicos

CONDICIONES IDEALES	CONDICIONES MÍNIMAS
• Un lugar seguro, confortable y privado, para todas las personas y para espacios de atención individual. • Temperatura confortable, especialmente si se cuenta con condiciones extremas que produzcan incomodidad en las personas. • Un lugar grande y con espacios disponibles para sentarse. • Contar con Servicios Sanitarios • Espacios que permitan la privacidad para atenciones individuales, pero a la vez cercanas al punto central en donde se ubique el resto de personas que requieren atención para generar mayor confianza. • Un lugar grande, con subdivisiones u oficinas. • Bien comunicado y céntrico. • Contar con material informativo y números telefónicos importantes para entregar a las personas. • Con disponibilidad de agua apta para el consumo humano, pañuelos desechables, comida y bebidas diversas.	• Un lugar seguro, confortable y privado, esto último al menos para las atenciones individuales. • Con posibilidad de obstaculizar la vista a terceros. • Con el espacio adecuado para que al menos las personas puedan sentarse. • Acceso de agua apta para el consumo humano y pañuelos desechables. • Con opciones de regular la entrada de personas y privacidad, ya que, en el caso de personas solicitantes de refugio y refugiadas, se debe proteger su identidad por motivos de seguridad. • Contar con material informativo básico o tarjetas para brindar seguimiento.

Fuente: Elaboración Propia a partir de Álvarez (2015). Módulo 1 de Curso Virtual de Primeros Auxilios Psicológicos de Universidad Autónoma de Barcelona.

Es recomendable al preparar al personal para que constantemente reciban información actualizada en distintas temáticas asociadas al interés de la población de interés como: salud, trabajo, procesos de regularización según categoría migratoria, protección, entre otros aspectos. Con esto, se pretende que las personas puedan poseer claridad al menos general sobre servicios disponibles, posibilidades de referencias y acceso a derechos, así como establecer contacto con personas clave que permitan facilitar las rutas establecidas por temas. En dicha línea, se recomienda consultar los protocolos establecidos por FUNPADEM, para contar con los insumos necesarios para un mejor abordaje, ya que la mayoría de las personas mostrarán preocupaciones asociadas a dudas asociadas con las temáticas mencionadas.

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Según Cortés y Figueroa (2015), en el Manual ABCDE para la aplicación de Primeros Auxilios Psicológicos de la Universidad Católica de Chile, Principalmente los PAPs sirven para los siguientes tres objetivos: Brindar alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación por medio de contactos e información y prevenir el desarrollo de psicopatología.

Sin embargo, otros autores describen funciones u objetivos más detallados. Según Esfera (2011) y IASC (2007), la primera ayuda psicológica describe una respuesta humana, de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. La PAPs trata los siguientes temas:

- Brindar ayuda y apoyos prácticos, de manera no invasiva.
- Evaluar las necesidades y preocupaciones
- Ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas (por ejemplo: seguridad, descanso, comida, agua e información), esto último es apoyado también por Hobfoll (1989).
- Escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen, hacerles sentir comprendidas, facilitando la expresión de sentimientos y la ventilación de emociones, esto es apoyado por Corral y Gómez (2009).
- Reconfortar a las personas y ayudarlas a sentirse calmadas.
- Ayudar a las personas para acceder a información, servicios y apoyos sociales
- Proteger a las personas de peligros posteriores.

Los PAPs buscan ofrecer ayuda de manera práctica y no invasiva centrándose en las necesidades y preocupaciones inmediatas de las personas, atenderlas en la medida de lo posible; escuchar al afectado sin sobre estimular a hablar sobre el tema; reconfortar a las personas y ayudar a la calma con técnicas de relajación; y psico educar, entre otras actividades. Parte importante es estar disponible para aquellos que necesiten apoyo y ayuda, de ninguna manera forzando u obligando a aquellos que no la necesitan o que se hayan negado a recibirla (OMS, 2012).

Desde la óptica de Deza (2007), lo principal es ayudar a la persona a recuperar su nivel de funcionamiento emocional equilibrado, que tenía antes del incidente que precipitó la crisis, o potencializar su capacidad creativa para superar el momento crítico.

Todas estas intervenciones tendrían la capacidad de generar un efecto psicológico que mitiga el estrés y la angustia, ayudando al afectado a restablecer el equilibrio biopsicosocial y minimizando el potencial de desarrollar un trauma psicológico (Hobfoll, 1989).

En adición, según Corral y Gómez (2009), también se debe contemplar: Reducir la mortalidad al entender el suceso estresor, ya que puede generar situaciones violentas como agresiones a otras personas o a sí mismo; actuando en consecuencia para evitarlo (desarrollar su red de apoyo informal, favorecer su ingreso hospitalario vía referencias, etc.).

PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN

Los orígenes de los PAPs se remontan según Cortés y Figueroa (2015) a mediados del 2000, con estudios asociados en atención posterior a eventos traumáticos, aunque también otros autores como Slaikeu (1985), realizó aportes importantes que sentaron bases fundamentales para los diversos aportes que se han presentado en los últimos años.

Por otro lado, Hernández, Gutiérrez y López (2014) plantean que históricamente se han propuesto ciertos principios por contemplar en la atención en crisis como: escucha responsable, transmitir aceptación, permitir libre expresión, proporcionar información, atmosfera de confianza y empatía. En esta línea, la extensa literatura hace referencia a estos principios y otros que se consideran de importancia para tomarse en cuenta a la hora de realizar este tipo de intervención durante o después de una crisis. A continuación, se detallan los más destacados:

- **Enfoque de derechos humanos:** Plantea que todas las personas, independientemente de su género, edad, cultura, nacionalidad o cualquier otra condición, son titulares de todos los derechos inherentes a los seres humanos. Este enfoque también plantea que el Estado y la sociedad en general deben garantizar los espacios, las oportunidades y las condiciones necesarias para que todas las personas desarrollen sus potencialidades y hagan uso pleno de sus derechos ciudadanos (OIM, 2018). Se entiende que no son las víctimas las que buscan su goce, sino que el Estado y la sociedad civil deben de garantizarlos (UNFPA, 2013).
- **Enfoque de género:** Considera el género como una construcción social y cultural que responde a una particular organización social del poder, que ubica a las mujeres y lo femenino en subordinación frente a los hombres y lo masculino. Por tanto, reconoce las diferentes condiciones de vulnerabilidad asociadas con el género que enfrentan las personas. Este enfoque obliga a mirar cualquier situación social o programa de intervención desde una perspectiva que permita entender las necesidades específicas de mujeres y hombres, y además, los efectos diferenciales de cada situación en ellas y ellos (OIM, 2018).
- **Dignidad:** Toda persona es única y valiosa, por eso se debe tratar a las personas con respeto y de acuerdo con sus normas culturales y sociales (Organización Mundial de la Salud, War Trauma Foundation y Visión Mundial Internacional, 2012). La dignidad es un atributo de toda persona sea individual o colectiva, y la Constitución considera a la dignidad humana, como algo natural de toda persona, limitándose a garantizarla, estableciendo para ello su carácter de inviolable. Es condición previa para el reconocimiento de los Derechos Humanos (Campos, 2007).
- **Confidencialidad:** Se deberá garantizar que la información brindada por las personas no se comparta con terceros y en caso de requerir conectar con otros profesionales para el acceso a derechos o suplir necesidades, se debe compartir únicamente lo necesario y solicitar previamente el consentimiento a la persona con su debida explicación del objetivo de compartir solo ciertos detalles. En el caso de situaciones de crisis o desastres, proteger la confidencialidad de sus interacciones con niños, adultos y familias puede ser un verdadero desafío, en especial dada la falta de privacidad existente en algunos entornos post crisis. Sin embargo, el mantener el grado más alto de confidencialidad en toda conversación que tenga con desastres es extremadamente importante (OIM, 2018).

El proteger la confidencialidad de sus interacciones con niñez, adolescencia, personas adultas y familias después de un desastre o evento traumático puede ser un verdadero desafío, en especial dada la falta de privacidad existente en algunos entornos. Sin embargo, el mantener el grado más alto de confidencialidad en toda conversación que tenga con las personas es extremadamente importante. Ésto cuenta con el sustento en la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, en donde se establece el deber de confidencialidad con los siguientes elementos:

La persona responsable y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligadas al secreto profesional o funcional, aun después de finalizada su relación con la base de datos. La persona obligada podrá ser relevado del deber de secreto por decisión judicial en lo estrictamente necesario y dentro de la causa que conoce (Artículo 11, Ley N°8968).

En dicha línea, dentro de la obligación de acatar las leyes del Estado costarricense, por se encuentra el deber de denunciar casos de abuso o negligencia, así como cualquier acto irregular que esté contemplado como delito o actividad con algún grado de sanción, especialmente cuando se trata de poblaciones vulnerables. Ésto se encuentra establecido en el Código Procesal Penal, en donde se establece la obligación a denunciar:

Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. b) Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier ramo del arte de curar, que conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté protegido por la ley bajo el amparo del secreto profesional. c) Las personas que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control y siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones (Artículo 281, Código Procesal Penal).

Si tiene dudas respecto de la divulgación de información, converse con sus superiores para una mayor orientación (National Child Traumatic Stress Network, 2006).

- **Seguridad:** Evitar que nuestras acciones provoquen mayor peligro o daño a las personas, asegurarse, hasta donde sea posible, de que a quienes ayudamos estén a salvo, y protegerlos de daños físicos o psicológicos (Organización Mundial de la Salud, 2012).
- **Respeto a la Cultura:** El tipo de contacto físico o personal que se considera apropiado puede variar de persona a persona, y de cultura o grupo social a otro. Por ejemplo, cuánto acercarse a alguien, cuánto contacto visual establecer, o si tocar o no a una persona, especialmente a alguien del sexo opuesto. A menos que esté familiarizado con la cultura del sobreviviente, usted no debe acercarse mucho, hacer contacto visual prolongado o tocar. Deberá estar pendiente de señales que le informen sobre la necesidad del sobreviviente de establecer un “espacio personal”, y familiarizarse con las normas culturales a través de los líderes comunitarios que mejor entiendan las costumbres locales. Cuando esté trabajando con miembros de una familia, entérese de quien habla por ella y haga el acercamiento inicial con esa persona (National Child Traumatic Stress Network, 2006).
- **Escucha Activa y Responsable:** La escucha debe darse durante el proceso de aplicación de PAPs de manera responsable, lo cual permita crear un espacio seguro para que las personas puedan externar sus experiencias y se sientan siempre escuchadas sin ser juzgadas por ello. Una vez compartan sus miedos y experiencias, se debe buscar el espacio para guiar la construcción de propuestas para la solución de sus principales problemas y dudas (Álvarez, 2015). Es necesario siempre pedir consentimiento para

ejecutar cualquier acción, así como informar sobre los beneficios o consecuencias de las mismas. Entre mejor sea la escucha, mejor será el apoyo (Ver Anexo N°1. Pasos para Realizar una Escucha Activa Adecuada).

- **No Revictimización:** Dupret y Unda (2013) mencionan que puede considerarse como la reiteración de una victimización, según lo indica la palabra, y que apunta a la reproducción de una situación de victimización anterior. La revictimización es, por tanto, una repetición de violencias contra quién ha sido previamente víctima de alguna agresión, aunque sea por omisión. Sin embargo, la palabra ha adquirido un sentido algo diferente, que sirve para referirse en especial a las vivencias de maltrato sufridas por las personas, en el curso de intervenciones institucionales después de que ocurre un evento traumático o violento, y remite por lo tanto a una falencia en el abordaje y tratamiento de la situación. En este sentido, se visualiza el reto del abordaje institucional, en donde no siempre se logra referir o atender adecuadamente a la persona, haciendo que nadie se responsabilice y la persona deba continuar explicando su situación en diversos espacios. La persona no es una cosa desechable, sino un ser humano que sufre y puede tener daños psico sociales tras no recibir un trato adecuado.

En síntesis, la revictimización se entiende como no hacer más daño a la persona haciéndola pasar por recordar aspectos traumáticos que pueden ocasionar una consecuencia mayor a nivel emocional o bien no propiciar soluciones a su situación (Ver Anexo N°2. Consejos para garantizar la No revictimización).

- **Validación:** Se debe dar importancia a todo relato, experiencia o emoción que la persona comparta y hacerle sentir que se le escucha. Nunca se debe emitir una opinión que minimice lo que la persona comparte, ya que no se conoce el proceso que ha debido enfrentar para verbalizar todo lo que expone y puede representar un gran paso. Además, se debe separar cualquier juicio de valor personal a la hora de emitir cualquier información o en cualquier etapa del abordaje, en donde dicho sea de paso es importante respetar las decisiones de las personas (Álvarez, 2015).
- **No Criminalización/culpabilización:** Muchas personas huyen de su país por conflictos armados o posiciones políticas, además algunas se desplazan por motivos económicos en búsqueda de mejores oportunidades o bien salen de sus países por situaciones de violencia que ponen en riesgo sus vidas; sea cual sea el motivo, el cual puede variar, se debe procurar que las decisiones que las personas toman en ese proceso, no sean juzgadas (Álvarez, 2015). En este sentido, se parte del derecho a migrar y buscar oportunidades de desarrollo donde ellos y ellas lo deseen.
- **Principio de No Discriminación/Respeto de la Diversidad:** Todas las personas tienen el derecho a recibir un trato justo y equitativo; para ello la raza, origen étnico, idioma, color de piel, género, idioma, religión, situación socioeconómica, orientación sexual, ser una persona con discapacidad, país de origen, identidad de género, opinión política o cualquier otra situación, no deben ser motivos para un trato diferenciado y que traiga repercusiones negativas por acciones discriminatorias (Álvarez, 2015). A partir de lo anterior, se puede brindar un abordaje que sea integral e interseccional (que reconozca los múltiples factores de vulnerabilidad y marginación que afectan a cada persona) para brindar la mejor atención a las personas y con un enfoque de respeto de los Derechos Humanos.

Por último, es necesario identificar ciertas situaciones que ameritan atención inmediata de especialistas, lo cual aplica en personas con: lesiones graves que ponen en riesgo su vida (requieren atención médica urgente), personas alteradas al nivel de no poder ocuparse de sí mismas o de quienes tienen a cargo y personas que pueden hacerse daño a sí mismas o a otras. Para conocer el abordaje adecuado a nivel integral de la población de interés en esta temática, se recomienda dar lectura del Protocolo de Acceso a la Salud, ya que con ello podrá contar con las herramientas para realizar un mejor abordaje.

FASES DE APLICACIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

Antes de aplicar los Primeros Auxilios Psicológicos, es necesario según Álvarez (2015) tener claros los siguientes aspectos para una preparación adecuada:

Información: Conocer el entorno donde se va a trabajar, así como la situación que ha ocurrido y conocer quién está providing asistencia y dónde.

Coordinación: Establecer comunicación con las personas autorizadas y coordinar acciones con las personas de instituciones clave para atender u orientar a la persona detectada.

Detección: Identificar quién necesita asistencia, prestar atención a cómo las personas reaccionan o interactúan con el entorno

Agrupación: Trabajar con las familias siempre que sea posible, así como con grupos espontáneos.

Concentración: Mantener un comportamiento sensible y respetando los principios establecidos en el apartado anterior. Además, es necesario demostrar calma y claridad de pensamiento.

Adaptación: Hay personas que pertenecen a distintos tipos de culturas, así como a otros grupos, por lo cual se debe respetar la diversidad de cada persona y las necesidades de las poblaciones de riesgo.

Por otro lado, según la Guía de Primera Ayuda Psicológica para trabajadores de campo de la Organización Mundial de la Salud (2012) se deben tener tres grandes aspectos en cuenta al aplicar los PAS, los cuales son:



OBSERVAR:

Comprobar la seguridad, si hay personas con necesidades básicas urgentes y si hay personas con reacciones graves de angustia.



ESCUCHAR:

Dirigirse a quienes pueden necesitar ayuda, preguntar sobre las necesidades o preocupaciones de las personas y escuchar de manera activa a quienes comparten su experiencia para ayudarles a tranquilizarse.



CONECTAR:

Ayudar a las personas a resolver sus necesidades básicas y acceso a servicios. Brindar información y ponerles en contacto con familiares o personas cercanas que sean parte de sus redes de apoyo social.

La aplicación de los Primeros Auxilios Psicológicos se deriva de prácticas desarrolladas en diversos campos profesionales. El modelo formulado en este manual incorpora aportes teóricos y de la experiencia del equipo consultor en una síntesis de pasos que recaban los aspectos más relevantes para que los CREDES puedan garantizar un proceso de acompañamiento adecuado para la población migrante.

Las fases indicadas están sujetas a variación o adaptación, y el orden propuesto puede variar según las circunstancias. Los conceptos y fases que se abordan se han construido paulatinamente, y dada la cambiante naturaleza de las crisis, será necesaria su actualización constante. Como se trata de una intervención de naturaleza de asistencia social, y no psicológica, requiere asegurar la satisfacción de necesidades básicas en primer lugar, como agua, alimento, techo, abrigo, seguridad, información, entre otros aspectos, para el apoyo de las personas. Todas estas intervenciones tendrían la capacidad de generar un efecto psicológico que mitiga el estrés y la angustia, ayudando a la persona afectada a restablecer el equilibrio biopsicosocial y minimizando el potencial de desarrollar un trauma psicológico, lo que es coherente con la Teoría de Conservación de Recursos (Hobfoll, 1989).

Los PAPs buscan ofrecer ayuda de manera práctica y no invasiva centrándose en las necesidades y preocupaciones inmediatas de las personas y atenderlas en la medida de lo posible. También se hace énfasis en escuchar a las personas afectadas sin sobre estimular que se refieran al tema emocionalmente sensible. Se procura reconfortar a las personas y ayudar a la calma con técnicas de relajación. Se busca además ayudarles a comprender su entorno y afrontar su estado emocional sin sentirse juzgados, mediante la psicoeducación. Parte importante de este proceso es estar disponible para aquellos que necesiten apoyo y ayuda, de ninguna manera forzando u obligando a aquellos que no la necesitan o que se hayan negado a recibirla (OMS, 2012).

A continuación, se detalla ordenadamente según diversos aportes, una propuesta que refleja un posible orden de aplicación, sin embargo, éste puede ser variado según las necesidades de la persona y el contexto.

FASES DE APLICACIÓN DE LOS PAPs

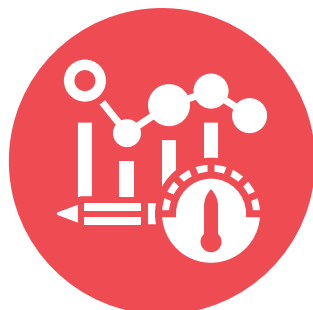
ENTRENAMIENTO

Lo primero es contar con un entrenamiento adecuado según cada contexto específico en PAPs (Cortés y Figueroa, 2015), en el caso de los CREDES, ha estado conformado por talleres como el desarrollado en las comunidades de acción del proyecto y utilizando el presente manual, para poseer respaldo de los elementos de importancia para su aplicación. Como se visualizó anteriormente, existen aspectos previos a tomar en cuenta, así como los pasos que se relatan seguidamente.



¿ESTOY EN CONDICIONES PARA BRINDAR PAPs?

Según Cortés y Figueroa (2015) es necesaria una auto-evaluación de la condición personal frente a la situación que expone la persona y antes de atender personas que han experimentado algún evento traumático. Si se encuentra afectada por alguna situación personal (duelo, crisis familiar, experiencia traumática reciente), es recomendable no efectuar la intervención a un tercero. De esta manera, evitará consecuencias negativas sobre sí mismo y sobre la persona afectada.



EVALÚE LA APLICABILIDAD

No todas las personas que experimentan una crisis van a necesitar PAPs, esto depende mucha de las capacidades de afrontamiento, por lo cual se debe priorizar a personas que han atravesado eventos traumáticos e indagar sobre síntomas desarrollados posterior al evento (mencionados anteriormente), si no se presenta ninguno, podríamos estar ante una persona que no requiera la aplicación de todos los pasos o fases de los PAPs.

Es muy importante respetar las decisiones y recursos propios de las personas, así como comunicar que usted estará disponible para ofrecer ayuda si la necesita más adelante. No olvide observar el lenguaje corporal y escuchar detenidamente a la persona desde el inicio de la intervención, si ésta se encuentra en una situación de emergencia psiquiátrica, la aplicación y los resultados de este protocolo pueden ser ineficaces, ya que es una persona que requiere de atención especializada (Cortés y Figueroa, 2015).

En dicho caso, lo mejor será referir a la persona al departamento de salud mental disponible en el Centro de Salud más cercano, tanto si la persona nos indica que posee una condición o bien si tenemos sospechas de que podría requerir evaluación del equipo de profesionales de dicha área.



CONTACTO, ACERCAMIENTO Y PRESENTACIÓN

El primer contacto con las personas es muy importante para aplicar los Primeros Auxilios Psicológicos, por ende, es necesario presentarse de forma no intrusiva, evitando el contacto físico, además de explicar por qué nos hemos acercado, establecer el entorno adecuado (confidencialidad, discreción, escucha activa, cómo trabajamos, etc.) Asimismo, puede establecer una relación de ayuda efectiva y aumentar la receptividad de la persona para continuar recibiendo ayuda (Álvarez, 2015).

Según Hernández y Gutiérrez (2014), los elementos más importantes deseados o recomendado para aplicar este paso son los siguientes:

- Preséntese con su nombre completo, cargo que ejerce y describa su rol.
- Pida permiso para hablarle a él/ella y explíquele con un tono de voz tranquilo y pausado que usted está ahí para ofrecer su ayuda.
- Invite a la persona a sentarse, trate de garantizar cierto grado de privacidad para la conversación y preste total atención a la persona.
- Hable suavemente, con calma y absténgase de mirar hacia otros lugares o distraerse.
- Entérese de la existencia de algún problema urgente que necesita atención inmediata, por ello procure durante todo el proceso indagar sobre las necesidades (National Child Traumatic Stress Network, 2006).
- Las inquietudes sobre asuntos de salud inmediatas tienen la máxima prioridad.



SEGURIDAD

En este apartado es necesario procurar la mejora de la seguridad inmediata de las personas, así como proveer el alivio físico y emocional de manera continua (Hernández y Gutiérrez, 2014).

Por otro lado, según National Child Traumatic Stress Network (2006), se debe restaurar un sentimiento de seguridad es una meta importante inmediatamente después de un evento traumático. Se puede proporcionar alivio y seguridad de diferentes maneras, entre ellas:

1	Asegurarse de contar con información actualizada y precisa, para evitar que las personas estén expuestas a información confusa o que produzca reacciones adversas.
2	Establecer enlaces con medios de apoyo que puedan aportar recursos prácticos.
3	Conseguir información sobre cómo mejorar las condiciones de seguridad específicas para la persona según su relato.
4	Apoyar a la persona para establecer conexiones con otros que hayan compartido experiencias similares.
5	Asegúrese de contar con apoyo apropiado que esté en capacidad de resolver problemas de seguridad que estén fuera de su control, tales como amenazas, armas, etc. Para ello recomendamos mantener a mano el Manual de Protección y tener vinculación con entidades como fuerza pública, Oficina de la Mujer o el OIJ en caso de requerir realizar denuncias específicas.

6	Remueva cristales rotos, objetos punzantes, muebles, líquidos derramados y otros objetos que pudieran causar tropiezos y caídas o algún otro evento indeseable.
7	Asegure de que la persona viene con menos de ocho días de poder cruzar, éstos pueden tener algún seguro para jugar y andar de bien adecuadamente supervisados.
8	Sea consciente y garantice la seguridad de grupos particulares, como es el caso de personas solicitantes de refugio, con quienes es muy importante conocer si se han sentido perseguidas o han recibido amenazas en el país de acogida.
9	Preguntar específicamente si necesita lentes, dispositivos auditivos, sillas de ruedas, andadores, bastones u otros artículos.
10	Pregunte si la persona posee alguna condición especial de salud o diversidad funcional que le impida realizar alguna tarea o bien que requiera atención médica o medicamentos específicos (estas personas deben recibir seguimiento).
11	Haga contacto con familiares, si están disponibles y la persona quiere contactarles, para garantizar aún más la seguridad, nutrición, medicación y demás.
12	Promueva el acercamiento social, propiciando que la persona se incorpore en algún grupo o que se pueda involucrar en actividades con personas en su misma condición, esto puede permitir generar redes de apoyo. Para ello, se recomienda mapear con Instituciones los grupos existentes.
13	Si la persona externa síntomas de depresión o estrés post traumático, lo mejor es monitorear si la persona presenta posibles riesgos de hacerse daño a sí misma o de morir, esto implica apoyo inmediato para contención y manejo de parte del equipo disponible en el Centro de Salud más cercano para prevenir éstas posibles implicaciones.



ALIVIO Y ESTABILIZACIÓN (PODRÍA NO REQUERIRSE)

En cuanto a la estabilización de las personas que son víctimas o testigos de eventos traumáticos, Hernández y Gutiérrez (2014) hacen referencia que al aplicar PAPs es necesario cubrir necesidades vitales básicas, así como propiciar la reagrupación familiar y propiciar un ambiente físico cómodo, con condiciones necesarias para que la persona se sienta en un entorno seguro a nivel físico y en cuanto a la atención que se brindará. Gran parte de las personas no necesitarán estabilización, sin embargo, es importante ser capaz de reconocer las características de las personas que si la requieren. Observe algunas de las siguientes señales de desorientación y agobio:

	Ojos cristalinos, mirada ausente o pérdida,
	Ausencia de respuesta a preguntas u órdenes verbales,
	Comportamiento desorganizado no intencionado,
	Respuestas emocionales intensas como llanto desconsolado, comportamiento agresivo, hiperventilación o movimiento de mecerse,
	Actividades de riesgo y reacciones físicas incontrolables.

Asimismo, según National Child Traumatic Stress Network (2006), cuando esté trabajando con personas con discapacidad o adultas mayores, preste atención a factores que puedan aumentar su vulnerabilidad hacia el estrés o empeorar sus condiciones médicas.

Según Cortés y Figueroa (2015) la “Escucha Activa” puede ser una herramienta para aliviar, contener emocionalmente, proteger y orientar temporal y espacialmente a la persona.

Para aplicar la técnica de la escucha activa y saber que se están siguiendo las pautas recomendadas para conseguir el objetivo mencionado por los autores anteriores, se pueden aplicar los siguientes pasos mencionados por Guillén, Paniagua y Arias (2011):



PARAFRASEO
Es una técnica de escucha mediante la cual, una vez que la otra parte se ha expresado, se repita en las propias palabras lo que se escuchó.



REFLEJO
Se busca identificar los sentimientos subyacentes en lo que la otra persona dice, y luego expresarle dicha interpretación con el fin de comprobar si uno está en lo correcto.



REFORMULACIÓN O REENCUADRE
Se procura expresar cuales fueron los intereses subyacentes que expresó la otra persona, pero dejando de lado aquellas cosas en las que la persona expresó negatividad, o técnicas manipulativas.

En este sentido, solo escuchar activamente a la persona puede representar un alivio debido a que promueve que ésta se sienta validada y valiosa. Es por esto que se recomienda no interrumpir a la persona, únicamente hacer preguntas de información que puedan ser clave para algún apoyo y que no quede clara. Posteriormente, externar que se comprende la situación y agradecer la confianza de compartir la información durante la sesión de asesoría o apoyo.

Es muy importante estabilizar a la persona para poder conocer sus necesidades y conversar adecuadamente, por lo cual podemos iniciar brindando un vaso con agua, un pañuelo desechable, aplicar con ella alguna técnica de relajación o respiración y acompañarle a un espacio más cómodo (si es posible) para que se pueda continuar con el apoyo, sin embargo, esto no siempre es suficiente por ello es necesario aplicar algunas técnicas que permiten alcanzar de manera exitosa el estado que se desea para intervenir (Ver Anexo N°3. Técnicas para Fomentar la Estabilización de las Personas).



RECOPILAR INQUIETUDES

Dentro de los aportes más destacados en su aplicación se menciona según Álvarez (2015) que es necesario identificar, analizar y explorar las necesidades y preocupaciones inmediatas de las personas tras pasar por situaciones traumáticas, para ello se debe reunir información adicional sobre las personas afectadas y en especial sobre los acontecimientos vitales estresantes previos. Así mismo, hacen mención que es necesario ordenar las necesidades encontradas y con base en ello planificar opciones para poder satisfacer o acceder a medios que permitan solventar esas necesidades existentes.

En la misma línea de los aportes anteriores, se recomienda que, durante la fase de recogida de información, nuestra forma de actuar es muy importante para que la persona no se sienta incómoda y para poder obtener la información que nos permitirá brindar una ayuda eficaz. Durante esta fase es importante por ende no trivializar o desvalorizar a las personas. Además, es de gran utilidad si ayudamos a la persona a levantar un listado de mayor a menor grado de importancia de necesidades inmediatas, esto puede facilitar visualizar qué requiere del apoyo en el momento como prioridad y qué podría incluso esperar un poco más por ser parte de un proceso mayor.

Por otro lado, según Hernández y Gutiérrez (2014) se menciona que en este paso en específico se debe contemplar lo siguiente:

- Cubrir necesidades vitales básicas, las cuales se identificarán desde el momento inicial de la conversación.
- Reunir información adicional sobre las personas afectadas, poner especial atención en recabar información sobre la existencia de personas menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazada, personas con discapacidad o personas con alguna condición de salud que pueda requerir de apoyo inmediato, así como atención y medicación para encontrarse en el mayor balance posible.
- Obtener información sobre acontecimientos vitales estresantes previos para entender el impacto de éstos en el bienestar de las personas afectadas para valorar la atención especializada en caso de ser necesaria.
- Ayudar a la reunificación familiar (En caso de que sea necesario, aunque no es lo más común).
- Especial atención a personas que tengan familiares en peligro, con enfermedades crónicas o de las cuales no poseen ningún tipo de información y que esto les genere ansiedad o estrés recurrentemente.

- Dar a conocer los apoyos disponibles según la información que la persona nos comparte y las necesidades manifiestas durante el proceso de recabar información sobre la condición de la persona.

En el caso de los aportes de National Child Traumatic Stress Network (2006), se contribuye a la comprensión de este paso en cuanto a que es necesario que la atención y la obtención de información sean flexibles al proveer los Primeros Auxilios Psicológicos, adaptando las intervenciones a individuos específicos cuyas necesidades y preocupaciones han sido identificadas. Por ello, es necesario obtener la información que permita adaptar la atención al máximo y establecer un orden de prioridades. El proceso comienza inmediatamente después del contacto y continúa durante todo el tiempo que se administran los PAPs.

Recuerde que en la mayoría de los entornos su capacidad para recopilar información estará limitada por el tiempo, las necesidades y prioridades de las personas. Aunque una evaluación formal no es apropiada, usted puede preguntar acerca de:

- La posibilidad de referir de inmediato a la víctima a instancias que garanticen satisfacer sus necesidades principales.
- La necesidad de servicios adicionales.
- Ofrecer una reunión de seguimiento.
- Utilizar componentes de los Primeros Auxilios Psicológicos que puedan ser útiles. En este sentido, el formulario Necesidades actuales del sobreviviente (Ver Anexo N°4), puede ser útil para documentar la información básica recopilada de los sobrevivientes. Asimismo, la Hoja de trabajo del proveedor de Primeros Auxilios Psicológicos (Ver Anexo N° 5) puede usarse para documentar los servicios provistos. Estos formularios están diseñados para ser utilizados dentro del sistema de comando de un incidente para propósitos de evaluación y cuando existen garantías de confidencialidad apropiadas.

En cuanto a la categorización de necesidades, según Cortés y Figueroa (2015) es importante que la persona utilice sus propios recursos o los de sus redes de apoyo personales o comunitarias para hacer frente a la crisis que está viviendo, de manera que lo logrado se mantenga luego de que usted termine su trabajo.



ASISTENCIA PRÁCTICA

Busca ofrecer ayuda práctica a las personas a atender las necesidades e inquietudes inmediatas. El proveer a las personas con los recursos que necesitan puede aumentar su sentido de fortalecimiento, esperanza y dignidad restaurada. La discusión de necesidades inmediatas ocurre a través del contacto con los Primeros Auxilios Psicológicos, en donde se apoya a las personas con necesidades prioritarias a ordenar sus prioridades y conocer las formas de solucionar o acceder a los recursos para solventar sus requerimientos, ya que debido al estrés y adversidad puede ser difícil asumir esta tarea en solitario (National Child Traumatic Stress Network, 2006).

En esta línea, es importante enseñar a los individuos a establecer metas alcanzables. Esto puede revertir los sentimientos de fracaso e inhabilidad para manejar la adversidad, ya que ayuda a las personas a tener reiteradas experiencias de éxito y ayudar a restablecer un sentido de control ambiental necesario para recuperarse exitosamente del evento traumático.

Dentro de lo recomendado por parte del Manual de Primeros Auxilios Psicológicos de National Child Traumatic Stress Network se menciona como base de esta etapa los siguientes pasos:

1. **Identifique las necesidades más inmediatas** (En continuidad con el apartado anterior el cual se mantiene permanente desde el primer momento de presentación hasta el final de la atención): Si la persona ha identificado varias necesidades o inquietudes, será necesario enfocarse en ellas una por una. Para ciertas necesidades, habrá soluciones inmediatas y otras requieren de un proceso más extenso, por ello se deben aclarar estos detalles a la persona.
2. **Clarifique la necesidad:** Procure que la persona logre especificar el problema o necesidades al máximo, ya que esto permitirá reconocer más claramente el proceso a seguir.
3. **Desarrolle un plan de acción:** Analice qué se puede hacer para atender las necesidades e inquietudes de la persona, puede indagar sobre qué desea que se haga o usted puede ofrecer una sugerencia. Si usted conoce los servicios disponibles de antemano o posee el contacto de actores clave que posean relación con apoyos a las personas, puede ayudar a obtener comida, ropa, techo, servicios de atención de salud integral gratuitos, etc. (Consultar Protocolos). En este aspecto, es muy importa informar siempre sobre lo que se puede esperar de manera realista en cuanto a la obtención de cada recurso y aclarar cuando se trata de procesos de solicitud, ya que en ocasiones las personas no logran identificar que no es una decisión a nuestro alcance, sino que es asumido por terceros que respetan ciertos criterios de selección. Ésto último, pretende no generar expectativas irreales que podrían generar un impacto negativo y ansiedad en las personas
4. **Actúe para atender la necesidad:** Ayude a que la persona pueda ser parte del proceso asumiendo algún tipo de acción, esto con el fin de ir generando empoderamiento sobre la situación y que la persona se sienta lo más parte posible del acceso a trabajar por suplir sus necesidades básicas. Por ejemplo, puede colaborarle a fijar una cita con un servicio que necesite o a completar el papeleo. Así como proponer soluciones que había considerado y nosotros orientarle con base en ello.



CONEXIÓN CON APOYOS SOCIALES

La conexión que se genera con actores clave que brindan distintos tipos de abordajes y servicios es de crucial importancia para la atención de poblaciones vulnerables, así como para la aplicación de los Primeros Auxilios Psicológicos. En este aspecto, fomentar la conexión con su red de apoyo, si la tiene, va a permitir a la persona adaptarse mejor a los cambios y a los efectos de la crisis que atraviesa, por ello según Álvarez (2015), si la persona no cuenta con una red instalada, se deben buscar opciones de apoyos que le permitan generar alguna a largo plazo.

Éste paso va en concordancia con los anteriores, ya que se busca no solo generar redes de apoyo con personas de los círculos sociales más cercanos, sino además conectar con organizaciones locales o nacionales en marco a las acciones de búsqueda necesarias para cumplir sus necesidades. Es por ello que Cortés y Figueroa (2015) proponen que una vez identificadas estas necesidades, es necesario ayudar a la persona a contactar a las personas y/o servicios de apoyo social que podrán ayudarle a satisfacer dichas necesidades ahora y más adelante, junto al material Servicios y Redes de Apoyo (ver Anexo N°6). Recuerde siempre que la primera red de apoyo es la familia y los amigos. Para este paso es indispensable que antes de contactar al afectado haya estudiado bien la oferta de servicios de apoyo social disponibles en el lugar donde proveerá los PAPs.

Según Hernández y Gutiérrez (2014) y National Child Traumatic Stress Network (2006), el apoyo social está relacionado con el bienestar y la recuperación emocional después de una crisis. Las personas que están bien conectadas con otras tienen mayor posibilidad de participar en actividades (tanto recibiendo como proporcionando apoyo) que asisten la recuperación de desastres. El apoyo social puede proveerse de muchas maneras. Éstas incluyen:

APOYO EMOCIONAL:	CONEXIÓN SOCIAL:	SENTIRSE NECESITADO:	FORTALECER LA AUTOESTIMA	APOYO FIABLE
Abrazos, disposición para escuchar, comprensión, amor, aceptación	Sentir que se lleva bien y tiene cosas en común con otras personas, tener personas con quien compartir actividades	Sentir que es importante para los demás, que es valorado, útil y productivo y que las personas lo aprecian	Tener gente que lo ayude a tener confianza en sí mismo y en sus habilidades, para que pueda enfrentar los desafíos que tiene delante	Tener personas que le aseguren que estarán con usted en caso de que los necesite; tener personas con las que puede contar

Todos estos aspectos son importantes para la adaptación y afrontamiento de la situación por parte de las personas que requieren de la aplicación de PAPs. Así mismo, es importante mantener constante la actualización sobre las Instituciones u Organizaciones a nivel local, provincial o nacional, ya que con esto las atenciones serán adecuadas.



INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE ADVERSIDADES

En este paso vamos a buscar proveer información sobre reacciones de estrés y manejo de adversidades para reducir la angustia y promover el funcionamiento adaptativo. Los eventos traumáticos pueden desorientar, confundir y angustiar, situación que pone a los sobrevivientes en riesgo de perder su capacidad para manejar los problemas que enfrentan. El sentir que uno puede manejar el estrés relacionado con el desastre y la adversidad es beneficioso para la recuperación. Varios tipos de información pueden ayudar a los sobrevivientes a manejar sus reacciones de estrés y a tratar más efectivamente los problemas. Esta información incluye (Hernández y Gutiérrez (2014) y National Child Traumatic Stress Network (2006):

- ¿Qué se sabe actualmente sobre el evento en desarrollo?
- ¿Qué se está haciendo para asistirlos?
- ¿Cuáles servicios están disponibles? ¿Dónde y cuándo los están?
- Reacciones post desastre y ¿cómo manejarlas?
- Cuidado propio, cuidado de la familia y manejo de adversidades
- Brindar pautas sobre estilos de vida saludable, es decir, recomendar a las personas: Seguir las técnicas de relajación expuestas anteriormente, mantener higiene del sueño (procurar dormir 7 u 8 horas como mínimo), alimentarse saludable y balanceadamente (si es posible), realizar algún tipo de actividad física, conversar con personas cercanas con quienes se sienta cómoda y mantenerse al tanto de su bienestar general.

CONEXIÓN CON SERVICIOS EXTERNOS O DE COLABORACIÓN

En esta etapa, se busca informar sobre todas las opciones existentes que puedan ser de interés para establecerse en el país o bien para el paso por el mismo (Ver anexo N°7). Provea enlace directo con los servicios adicionales necesarios para la persona cuando se acabe la atención y también los que se vinculan con el seguimiento de sus necesidades y preocupaciones. Haga lo que sea necesario para asegurar la conexión efectiva con esos servicios (por ejemplo, acompañe, si le es posible, a la persona a donde está el representante de la instancia que puede proveer el servicio). Algunos ejemplos de pautas a seguir son las siguientes:

- Brindar tiempos aproximados para pedir ayuda a un especialista en el caso de que la sintomatología de estrés agudo persista o aparezcan nuevos síntomas.
- Dejar conectado con la red de salud pública o servicios análogos.
- Conocer los procesos legales regulatorios a nivel migratorio en el país, así como de solicitud de refugio y facilitarlo, si la persona así lo desea. Si no se posee la información, referir a las organizaciones que abordan el tema. Siempre explicar a la persona que migración y extranjería trabaja de manera aparte, ya que constantemente se posee un miedo generalizado en la institucionalidad por miedo a una posible deportación.
- Reforzar el mantener un contacto adicional en caso de crisis, así como referencias en caso de ser necesarias.
- Si se posee, compartir panfletos con información de interés, ya que algunas personas llegan sin ningún medio de comunicación al alcance, por lo cual tendrán que acudir de manera presencial o por medio de préstamos de teléfonos a los servicios por mientras que logran poseer medios propios.
- Recordar sobre las pautas de afrontamiento y reacciones esperadas posterior a un evento traumático, así como indicar a la persona seguir un estilo de vida lo más saludable posible según su alcance para mantener la mayor estabilidad posible.

SEGUIMIENTO

Según Slaikeu (1988) es importante en cuanto al seguimiento en Primeros Auxilios Psicológicos contemplar lo siguiente:

El objetivo del seguimiento es, ante todo, completar el circuito de retroalimentación, o determinar si se lograron o no las metas de los primeros auxilios psicológicos: el suministro de apoyo, reducción de la mortalidad y cumplimiento del enlace con fuentes de apoyo. Además, el seguimiento facilita otros pasos hacia la resolución de la crisis. Esto permite al asistente el hacer operativas las soluciones posteriores, ya descritas (como la remisión a una subsecuente terapia para crisis). En cada caso, existe una verificación de si la solución inmediata fue apropiada o no para la necesidad inmediata. Si las necesidades inmediatas fueron confrontadas con una de las soluciones inmediatas acordadas, seguido esto por los pasos de acción concreta, y se ha completado el enlace para las necesidades posteriores, entonces está completo el proceso y terminaría la responsabilidad del consejero/asistente, a menos que el proceso quede inconcluso o sea una persona con una situación particular. El proceso continúa entonces a través de las posibles soluciones, la acción concreta y el seguimiento (p.27).

En este sentido, es importante tener en cuenta que algunas personas podrían requerir de seguimiento, ya que algunas podrían tener condiciones que les impide comprender los pasos a seguir con sus necesidades o bien son procesos más extensos que requerirán de la asignación de citas con la persona para poder seguir de cerca el proceso. Es por ello que se debe procurar mantener la claridad en toda la comunicación y en lo que se requiere para satisfacer las necesidades básicas de la población de interés. Para el seguimiento de manifestaciones en diversas áreas, se recomienda ver el Anexo N°8.

RECOMENDACIONES PARA ABORDAR DISTINTOS GRUPOS ETARIOS

Cada grupo etario tiene un desarrollo cognitivo distinto, por ende, cada uno va a asimilar de manera distinta las situaciones que se pueden presentar según el contexto. A diferencia de las personas adultas y adolescentes, según la Universidad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona (2018) en niñas y niños de los 0 a los 12 años, se manejan las siguientes fases: Contener, Calmar, Informar, Normalizar y Consolar. Ésto debido a que las personas requieren un proceso más simple y con menor grado de complejidad, además de que en ocasiones las personas a cargo serán facilitadoras también del proceso, el cual nunca debe ser obligatorio y siempre se debe procurar conversar al nivel de la persona para evitar una imagen de desconfianza y hermetismo.

Save the Children (2013) menciona que la mayoría de los niños y niñas sobreviven los acontecimientos angustiosos sin desarrollar problemas de salud mental a largo plazo y muchos se recuperan por sí mismos. Sin embargo, se les puede ayudar a recuperarse brindándoles un apoyo apropiado en las primeras etapas, lo cual reduce de manera espectacular su riesgo de desarrollar problemas de salud mental a largo plazo.

A continuación, se esquematiza cómo se deben aplicar en los grupos etarios por describirse:

Tabla N°2. Fases de Aplicación de Primeros Auxilios Psicológicos en Niñez

EDAD	¿CÓMO ACTUAR?
0-3 años	-Contener: Evitar separarse del niño/a, reconducir las conductas de apego físico exagerado, dar un espacio para el llanto o el grito controlado. -Calmar: Ayudarlo a relajarse, hacer que se sienta comprendido, facilitar la liberación de energía nerviosa, con niños mayores de dos años ayudar a poner nombre a las emociones es de utilidad. -Informar: Intentar explicarle en un lenguaje adaptado a su edad cuál es la situación, utilizar frases cortas y sobretodo que pueda entender que no está solo y qué pasará a continuación, no ocultarle información o mentirle, decir a menudo que le entiende. -Normalizar: Establece una rutina para ir a dormir adaptada a la situación, no obligarle a comer si no tiene hambre, intenta realizar las comidas en un ambiente lo más relajado posible, establecer límites razonables para las rabietas (Si las hay) -Consolar: Procurar hacer actividades positivas con el niño/a, escuchar cuando el niño/a hable, permitirle tener control de cosas pequeñas, ayúdalo a expresar sus sentimientos a través de actividades lúdicas.
3-6 años	-Contener: Asegurar la comodidad y descanso -Calmar: Usar voz baja y suave, procurar actividades relajantes, distraerle con elementos de su agrado. -Informar: Usar un lenguaje adecuado para su edad, explicar lo ocurrido de forma simple y honesta, tratar de responder a todas sus preguntas, explicarle las diferencias entre los sueños, los miedos y la vida real. -Normalizar: Poner nombre a las emociones, pueden aparecer aparición de conductas agresivas y regresiones, por ende, se le debe relajar y hacer sentir en un espacio seguro. -Consolar: Ayudarlo a entender qué ha ocurrido, mantener las rutinas familiares (si es posible), permitirle que realice tareas productivas, no se debe obligar a hablar.
6-9 años	-Contener: Tratar que las emociones se expresen, equilibrar la ventilación y escuchar sus miedos. -Calmar: Hablar en voz baja y pausada, apoyar para que se tranquilice, no decir nunca que si se calma, todo irá mejor, manejar siempre la sinceridad. -Informar: Utilizar palabras y explicaciones simples, responder a todas sus preguntas, no dar más información de la que nos pide el niño, averiguar qué sabe el niño o niña, porque posiblemente haya oído información a medias que le asusten, porque no las comprende. -Normalizar: Ayudar a expresar cómo se siente, poniendo nombre a sus sensaciones y animarle a hacerlo, sin forzar nada. Si reacciona con irritabilidad, en lugar de ignorarle, comentar con voz suave que entendemos lo que siente y que estamos para escucharle. -Consolar: Animar al niño o niña a dibujar y/o jugar acerca de lo ocurrido, permitirle volver a la escuela y a las actividades habituales para fomentar su vida social.
9-12 años	-Contener: Lograr equilibrio de la ventilación, dejar espacio para que puedan estar solos, pero no excesivamente. -Calmar: Hablar en voz pausada y serena, apoyar para que se pueda tranquilizar. Se le debe permitir distraerse con algo que le agrada. -Informar: Usar un lenguaje adulto, pero sencillo, responder con claridad y sin evasivas a sus preguntas, no dar más información de la que se nos pide, pero invitar a formular más preguntas, si no quiere saber nada, puede que busque evitar el dolor, en dicho caso retomar el tema al día siguiente. -Normalizar: Animar a expresarse, sin forzarle a ello, explicarle que hay muchas formas de estar triste y está bien, que conversar puede ser de ayuda para sentirse mejor. -Consolar: Animar a explorar qué actividades les ayudan a estar mejor y a realizarlas, permitirle volver a la escuela y a las actividades habituales cuando se sienta preparado, fomentar el contacto y el tiempo con su grupo de iguales.

Fuente: Elaboración propia a partir de curso de Primeros Auxilios Psicológicos, UAB, Álvarez (2015)
Además de las recomendaciones anteriores el Manual de Primeros Auxilios Psicológicos de National Child Traumatic Stress Network (2006), para trabajar con niñez, adolescencia y personas adultas mayores, se recomienda lo siguiente:

	NIÑEZ • Con niños pequeños, siéntese o arrodílese a nivel de la vista del niño. • Ayude a los niños de edad escolar a que verbalicen sus sentimientos, preocupaciones y preguntas; provea categorías simples para reacciones emocionales comunes (por ejemplo, enojado, triste, asustado, preocupado). • Escuche cuidadosamente y utilice un lenguaje simple. • Sea consciente de que los niños y las niñas pueden exhibir regresión en el desarrollo de su comportamiento o uso del lenguaje • Refuerce estas técnicas con la madre- el padre/cuidadores para ayudarles a éstos a brindar a sus hijas e hijos el apoyo emocional apropiado.
	ADOLESCENCIA • Se puede conversar en un tono normal, como a una persona adulta. • Aplique los mismos pasos que se abordaron anteriormente para personas adultas. • Refuerce estas técnicas con la madre- el padre/cuidadores para ayudarles a éstos a brindar a sus hijas e hijos el apoyo emocional apropiado.
	PERSONAS ADULTAS MAYORES • Los adultos mayores tienen tanto fortalezas como vulnerabilidades. Muchos adultos mayores han adquirido destrezas para manejar situaciones adversas a lo largo de sus vidas. • Para aquellos que tengan dificultad para oír, hable claramente y en un tono adecuado (no hay que hablar de ésta forma a todas las personas, ya que algunas no tienen ningún tipo de deterioro auditivo y puede ser irrespetuoso). • No haga suposiciones basadas sólo en la apariencia o edad, como • Un adulto mayor con una discapacidad de salud mental puede estar más alterado o confundido en entornos que no le son familiares. Si identifica a un individuo así, haga adecuaciones para brindar la consulta o refiéralo a un especialista de salud mental.

Todos los grupos etarios son importantes y quienes ejercen la atención son quienes pueden y deben adecuar la comunicación y otros elementos para garantizar la mejor atención posible. Cada grupo además cuenta con necesidades particulares, en especial niñez y personas adultas mayores, en especial si son personas con discapacidad o poseen alguna condición de salud determinada.

ASPECTOS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA

Debemos acudir a un profesional especializado si los síntomas de estrés agudo que se han descrito anteriormente, que se pueden presentar tanto en niñez como en personas adultas, persisten posterior a un aproximado de un mes. Si esto sucede, lo ideal es referir a una persona profesional de la salud mental como psicología.

En el caso de niñez, hay que recordar que cada una y uno son diferentes, por ende puede haber casos distintos, por eso siempre lo mejor es asistir, pero también dar el espacio necesario para asimilar las situaciones. Si la persona menor no posee la confianza o interés de trabajar con alguien de los equipos que aplican los PAPs, se pueden brindar pautas según lo mostrado en la tabla anterior para que algún miembro de la familia lo pueda realizar, o al menos abrir un espacio para conversar del tema y los sentimientos que han surgido.

Se debe contemplar que cuando se atiende a personas adultas, si vienen acompañadas de alguna persona menor de edad, se le debe saludar de igual manera, ya que no se recomienda ignorarles, ya que también merecen validación.

Además, durante el proceso se debe recalcar la importancia de poseer un estilo de vida lo más saludable posible, así como evitar del todo el consumo de alcohol, drogas y azúcar, ya que esto puede empeorar las condiciones de las personas que son víctimas de eventos traumáticos. En esta línea Gonçalves (2013), recomienda hacer ejercicios físicos para ayudar a la metabolización de la adrenalina segregada, la práctica de técnicas de relajación, meditación, visualizaciones, yoga, etcétera, así como mantener una dieta adecuada.

PRACTICANDO LO APRENDIDO (EJEMPLO DE CASO)



Bianca es una mujer activista feminista y ecologista nicaragüense, ella estuvo involucrada como organizadora y partícipe en las manifestaciones en contra del Régimen de su país, además, articuló esfuerzos para hacer denuncias públicas sobre lo que sucedía en su comunidad.



A los días del evento, ella se percata de que todos los días un vehículo “pick-up” marca Toyota Hilux se parquea frente a su casa, el cual parece pertenecer a fuerzas paramilitares del régimen autoritario.



Al parecer, hace unos días una de sus vecinas fue secuestrada y ahora se encuentra privada de libertad sin motivo alguno.



Un día, ella sale a realizar unas compras y se da cuenta por medio de una amiga que allanaron su casa mientras no estaba y que al parecer el objetivo de dicho evento fue llevarla al mismo centro penitenciario en donde se encuentra su vecina, en donde cuentan que las personas están siendo torturadas.



Bianca decide irse del país inmediatamente con lo único que llevaba en su bolso. Por miedo a ser identificada, pasa la frontera de manera irregular y logra llegar a Peñas Blancas, en donde logra encontrar un puesto de la Cruz Roja. Está embarazada y teme por su salud, ya que lleva dos días sin comer y se ha sentido algo enferma.



Cuando llega a este puesto de atención su condición anímica está visiblemente muy alterada. Tiene problemas para respirar por la agitación, está llorando porque no sabe qué hacer y además tiene señales de estrés agudo por la persecución que ha atravesado.



Al llegar a Cruz Roja, Bianca es valorada físicamente por parte de una persona funcionaria, la cual decide llamarla a usted como funcionaria del CREDES disponible para abordar mejor a la persona, ya que esta persona no conoce los procedimientos a seguir para aplicar los Primeros Auxilios Psicológicos y tampoco conoce las rutas de referencia para las personas migrantes o solicitantes de refugio.

EJERCICIO PRÁCTICO (VER PROPUESTA DE ABORDAJE EN ANEXO N°9)

¿Qué pasos se recomienda que debe seguir usted para atender adecuadamente a Bianca?

Anote en cada cuadro las acciones más importantes que debe tomar según cada fase de aplicación del proceso de brindar Primeros Auxilios Psicológicos (PAPs).

1. ¿Poseo el entrenamiento y las condiciones para brindar la atención? Si () No ()
2. ¿Son aplicables los PAPs en este caso? Si () No ()
3. Contacto, acercamiento y presentación:

4. Seguridad:

5. Alivio y Estabilización:

6. Recopilar Inquietudes (Needs and Worries):

7. Asistencia Práctica:

8. Conexión con Apoyos Sociales:

9. Información sobre el manejo de adversidades:

10. Conexión con servicios externos o de colaboración:

11. Seguimiento:

CONCLUSIONES Y MÁS RECOMENDACIONES

Es importante que las personas que aplican los PAPs, sepan identificar signos de burnout, un síndrome que aparece cuando las personas están demasiado exhaustas por el trabajo. Por eso es necesario promover espacios de autocuidado al equipo y a nivel individual, ya que, si las personas del equipo no están cultivando su salud mental, les será más difícil un abordaje correcto con las demás.

Para realizar las atenciones, hay que tener presente que se debe evitar usar tecnicismos, además de que es importante actualizarse sobre la aplicabilidad de técnicas que puedan ayudar a las personas para aliviar sus preocupaciones y consecuencias de las crisis. Un equipo bien informado, orienta mejor y sabe ejercer una escucha activa adecuada.

Además, es clave que la comunidad logre establecer algún comité, comisión o equipo que trabaje desde distintos organismos e instituciones para que puedan responder adecuadamente a eventos que requieran de la aplicación de los Primeros Auxilios Psicológicos. En este punto, la comunicación será esencial para garantizar la coordinación y articulación.

Es importante además tener claro que esta metodología no aplica para todas las personas, ya que no todas la requieren, por tal razón debemos asistir principalmente a quienes demuestran signos de no sentirse ubicados y que requieren de una orientación urgente, así como de la escucha.

Aplicar todos los aspectos demostrados en este manual, pueden beneficiar notoriamente a las personas, pero no se deben olvidar los principios de la atención, sus etapas y recomendaciones que siempre deben partir desde un entrenamiento previo, ya que es una gran responsabilidad trabajar con personas en condiciones de vulnerabilidad emocional y de otros aspectos.

ANEXOS

A continuación, se presenta un conjunto de material adicional que pretende reforzar los contenidos abordados en el Manual, así como proporcionar herramientas de utilidad para contemplarse. Es importante realizar lectura de los mismos e identificar los que considere de mayor relevancia.

Uno de los principales aportes, son las plantillas de instrumentos elaborados por National Child Traumatic Stress Network (NCTSN), que pueden obtenerse en la siguiente dirección.
<https://www.nctsn.org>.

Estos materiales cuentan con la autorización para su uso, su distribución a otras personas e imprimir copias adicionales siempre y cuándo se reconozca el crédito y se mantenga su forma actual sin modificar, incluyendo los títulos, logos y pies de página, y con la condición de que no se realice ningún cobro por ellos. Se recomienda seguir el vínculo anteriormente provisto para obtener más información sobre los recursos que ofrece esta entidad.

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO	PÁG.
Anexo N°1. Consejos para una Escucha Activa Adecuada	42
Anexo N°2. Consejos para Propiciar la No Revictimización	43
Anexo N°3 Técnicas para Fomentar la Estabilización de las Personas	44
Anexo N°4. Formulario para Identificación de Necesidades Actuales	47
Anexo N°5. Hojas de trabajo Personas Proveedoras de Primeros Auxilios Psicológicos	49
Anexo N°6 Conexiones con Servicios y Redes de Apoyo	51
Anexo N°7. Lista de Recursos Locales que Puede Ser de Utilidad	54
Anexo N°8. Reacciones Emocionales, cognitivas, Físicas e Interpersonales Comunes Frente a Experiencias Traumáticas Recientes	55
Anexo N°9. Propuesta de Abordaje del Ejercicio Práctico.	56

ANEXO N°1. CONSEJOS PARA UNA ESCUCHA ACTIVA ADECUADA

Las técnicas de escucha activa son importantes cuando se trabaja en atención a personas en situaciones de vulnerabilidad y en la comunicación en general. Es por ello que la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos (2012) recomienda siete técnicas específicas (que se resumen por las iniciales: 2 P y 5 R), los cuales se resumen a continuación (Pp. 15-16):

	Parafrasear: Es decir lo expresado por la otra persona, casi con las mismas palabras. Utilizando frases como: "Déjeme ver si le entendí", "veamos, lo que comprendo de su situación es...".
	Preguntar: Es realizar preguntas abiertas o cerradas para definir el conflicto que está sucediendo, es una forma de obtener más información. Sin embargo, manténgase más enfocada en las preocupaciones de la persona que en "extraer información".
	Resumir: Después de una conversación, se resume de forma positiva lo dicho por la persona y se rescatan los puntos más importantes del relato.
	Reflejar: Es un parafraseo de los sentimientos de las personas. Tiene incidencia en un ámbito emocional, sin embargo, no es inferir sentimientos, es hacer notar lo evidente. Por ejemplo: "veo que ese tema le molesta o le incomoda, ¿es así?".
	Reencuadrar: Es una forma de volver al tema central que se estaba tratando de resolver, esto porque muchas veces las personas, mencionan temas que pueden abordarse posteriormente al no ser los más prioritarios. Ejemplo: "entiendo, si gusta podemos resolver primero los temas más urgentes y posteriormente indagamos al respecto, ¿le parece?".
	Reconocer: Es una técnica en la que la persona encargada de la atención muestra que presta atención a los relatos, ya que refuerza actos positivos. Ejemplo: "Fue muy responsable de su parte acercarse a las instancias correspondientes..."
	Revalidar: Reforzar y reafirmar lo planteado o expuesto por la persona, así como los acuerdos establecidos. Por ejemplo: "entonces, como ya usted lo indicó, podemos agendar otra cita la próxima semana para dar seguimiento a su caso y que así se encuentre más tranquila".

Según Guillén y Paniagua (2006, p. 22). En el momento de la interacción en que el enfoque se encuentra en brindar una escucha activa y empática, es importante evitar algunas conductas que no constituyen una adecuada conexión empática. Aunque algunas de ellas puedan ser realizadas en algún momento posterior.

- aconsejar según criterios subjetivos o que brinden un juicio de valor de la situación.
- No dejar que la persona exponga su relato y no dejarla hablar al interrumpirle constantemente de manera innecesaria.
- Minimizar la situación de la persona como si fuera algo muy simple o sin importancia, ya que no sabemos hasta qué punto esa persona tuvo que atravesar muchos obstáculos o violencia para poder externar su relato.
- No es una competencia o comparación, por ende no compare las situaciones con su vida personal, estamos para escuchar a la persona y apoyarla para que se sienta comprendida y apoyada en la búsqueda de soluciones, desde su experiencia.
- Compadecerse con frases como: “Pobrecitos ustedes”.

ANEXO N°2. CONSEJOS PARA PROPICIAR LA NO REVICTIMIZACIÓN

A raíz del trabajo realizado por parte del equipo consultor a una gran cantidad de personas migrantes en donde se ha promovido la no revictimización, se recomienda desde experiencias obtenidas a las funcionarias de los CREDES que, al trabajar con personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas se debe tener en cuenta este principio, procurando tener en cuenta lo siguiente:

1	Dar información clara sobre procesos de documentación, proceso de solicitud de refugio, acceso a derechos, apoyos específicos de organizaciones o equipos interinstitucionales.
2	Cumplir lo que se acuerda o promete, por mínimo que sea, ya que es violento generar expectativas que no se pueden cumplir. Siempre ser transparentes con los procesos e indicar cuando no es posible contar con algún recurso.
3	Tener una escucha responsable y respetuosa, sin emitir juicios de valor.
4	Permitir que la persona comparta su testimonio siempre y cuando ello tenga un sentido para ella o para el proceso. Si esto es así, hacer sentir a la persona lo más cómoda y escuchada posible, pero nunca pedir datos extra que no sean relevantes para la atención y que puedan abrir espacios emocionales referentes a la actualidad o el pasado para los que no se está en capacidad de abordar.
5	Proteger de posibles situaciones de vulnerabilidad a grupos con condiciones que puedan requerir de la activación de protocolos específicos (Personas con VIH, Discapacidad, Menores de edad no acompañados, víctimas de violencia basada en género, víctimas de trata o tráfico, sobrevivientes de tortura o persecución, comunidad LGBTQ+, entre otras) (Apoyarse en Protocolos).
6	Privacidad y confidencialidad en el manejo de la información brindada por la persona. En los casos en los que sea necesario compartir la información (Lo más breve posible con los detalles relevantes) con otros profesionales se consultará primero la autorización para compartir la información y explicando porqué es necesario hacerlo.
7	Derivar a los profesionales o servicios adecuados para que puedan continuar con la atención integral necesaria.

ANEXO N°3 TÉCNICAS PARA FOMENTAR LA ESTABILIZACIÓN DE LAS PERSONAS

Dentro de algunas de las técnicas más mencionadas en diversos manuales, protocolos, artículos y guías en la línea de la aplicación de PAPs se recomienda para estabilizar (cuando se requiere) a las personas, se encuentran las siguientes:

- a. Reentrenamiento de la Respiración (Cortés y Figueroa, 2015):** Si la persona se encuentra sumamente afectada por el evento traumático, puede mostrarse ansiosa, confusa o alterada; lo que puede manifestarse con: temblores, dificultad para respirar, palpitaciones fuertes. Además, puede que al empezar a conversar rompa en llanto o presente una ansiedad extrema que obstaculice la respiración. Ante todo, lo anterior, la técnica contempla unos minutos para enseñar y practicar el “reentrenamiento de la ventilación” y así ayudarle a tranquilizarse.

Este paso toma 10 minutos, aunque habrá personas que necesitarán más tiempo (Recuerde que este y otros pasos pueden aplicarse siempre y cuando la persona quiera recibirlo).

Antes de iniciar, explique que la forma como respiramos influye en nuestras emociones, y que es por eso que en el yoga y la meditación se trabaja con la respiración. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo aplicar la técnica:

1. Diríjase a la persona y explique: “Ahora ensayaremos el re-entrenamiento de la respiración: consiste en inspirar, exhalar y luego esperar un momento con los pulmones vacíos hasta volver a inspirar... lo importante es la pausa luego de vaciar los pulmones, podemos hacerlo en cuatro tiempos, por lo cual requiero que esté atento al conteo”
2. Puede pedirle que lo practiquen juntos.
3. Para empezar, pídale a la persona que adopte una postura relajada y cómoda, poniendo los pies en el piso y sintiendo ese contacto. “Si lo desea y se siente cómodo, puede cerrar los ojos o mirar un punto fijo con la mirada baja. Ahora vamos a intentarlo...”



(imagen de muestra)

b. Grounding o Enraizado (Hernández y Gutiérrez, 2014): Si la técnica anterior es insuficiente, la persona vuelve a desestabilizarse o bien queremos iniciar con este método, podemos presentar esta técnica diciendo:

1. “Después de una experiencia tan terrible, a veces uno se encuentra abrumado con emociones o no puede dejar de pensar en lo que sucedió o de imaginárselo. Puede utilizar un método que se llama ‘enraizado’ para sentirse menos abrumado. El enraizado funciona porque logra que sus pensamientos se dirijan nuevamente hacia el mundo externo.
2. Explicar a la persona los pasos a seguir:
 1. Siéntese en una posición cómoda sin cruzar sus piernas o brazos.
 2. Respire hacia adentro y hacia afuera lenta y profundamente.
 3. Mire a su alrededor y mencione cinco objetos que no le causan angustia. Por ejemplo, usted puede decir “veo el suelo, veo un zapato, veo una mesa, veo una silla, veo a una persona”.
 4. Respire hacia adentro y hacia afuera lenta y profundamente.
 5. Ahora, mencione cinco sonidos que puede escuchar que no le causan angustia. Por ejemplo: “oigo a una mujer hablando, me oigo a mí mismo cuando respiro, oigo una puerta que se cierra, oigo a alguien escribiendo en el teclado, oigo un teléfono celular sonando”.
 6. Respire hacia adentro y hacia afuera lenta y profundamente.



3. **Respiración Consciente (Foa, Hembree y Rothbaum, 2007):** Dentro de las técnicas utilizadas por diversos profesionales y a nivel holístico, se establece el ejercicio de la respiración consciente, el cual consiste en lo siguiente:
 - Se debe explicar a la persona que es una técnica para facilitar el flujo de oxígeno en el organismo, por lo cual le invitaremos a prestar atención al ejercicio detenidamente, en donde deberá adoptar una postura relajada y cómoda, poner los pies en el piso y sintiendo ese contacto (puede cerrar los ojos). Inspirar en 4 tiempos, lo que implica la retención con los pulmones “vacíos” (4 tiempos) y exhalar por la nariz o boca (4 tiempos). Los tiempos son variables, según el nivel de agitación de la persona. Acomode la duración de los tiempos para que el afectado se sienta cómodo y no se quede sin aire.
 - El ejercicio debe repetirse cuantas veces sea necesario y se recomienda acompañar a la persona a hacer el ejercicio y brindar estímulos positivos durante su aplicación.
 - Al terminar, es importante indicar a la persona afectada que es recomendable que lo repita diariamente por diez minutos, tres veces al día (mañana, tarde y noche) y cada vez que se sienta angustiada. Puede ayudarse con las aplicaciones como “siente-minfulness” y psicología positiva o Breath Pacer disponible para teléfonos inteligentes.

4. **Meditación (Simon, 2006):** Se define como el proceso a través del cual, la persona observa y se hace consciente de lo que está sucediendo a cada instante en su cuerpo y en su mente, aceptando las experiencias que se van presentando tal y como éstas son. Esta práctica, tiene como fin la eliminación del sufrimiento y demás emociones destructivas, ya que se parte de que, tanto la felicidad como el sufrimiento no dependen fundamentalmente de las circunstancias externas, sino de la propia mente y como lo afronta. De ello se deriva el “Mindfulness”, que es el denominador común que se encuentra en la base de diferentes corrientes de meditación derivadas de la tradición budista y que actualmente se han incorporado a diversos modelos de tratamiento en psicoterapia. La técnica puede ser muy efectiva en procesos de terapia e incluso puede ser utilizada si las personas no solamente quieren tener un grado de relajación, sino además para poder conciliar el sueño.

Esta técnica podemos recomendarla como parte de las actividades por realizarse posteriormente en casa o en un ambiente que represente un espacio seguro y de relajación para la persona. Podemos recomendar a la persona visualizar en internet algunas personas que aplican la técnica para poder recibir una guía sobre los pasos a seguir, a continuación, se recomiendan los siguientes links:

<https://mettaapps.com>

Vicente Simón, Universidad de Valencia <https://youtu.be/7VULfVBcYKE>

Todas las técnicas mencionadas han sido avaladas por diversos autores y han sido puestas en práctica en diversas situaciones, lo cual es validado por Hernández y Gutiérrez (2014) quienes aportan que: “existen diversos métodos que permiten alcanzar la calma y reducir el estrés. Estas técnicas implican diversos beneficios para la salud, ya que ayudan a disminuir la tensión muscular, la presión arterial y el ritmo cardíaco”. Por esta razón, es posible aplicar cualquiera de las opciones o incluso explorar bajo evidencia científica otros métodos que pueden significar un aporte importante tanto para las funcionarias de los CREDES, como a las personas de interés de la ventanilla como una herramienta para aliviar la ansiedad y el estrés que suelen aparecer constantemente tras un proceso traumático como una migración forzada o una migración económica.

ANEXO N°4. FORMULARIO PARA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES ACTUALES



Hojas de trabajo del proveedor

Necesidades actuales del sobreviviente

Fecha: _____ Proveedor: _____

Nombre de sobreviviente: _____

Ubicación: _____

Esta sesión se llevó a cabo con (marque todos los cuadros que correspondan):

☐ Niño ☐ Adolescente ☐ Adulto ☐ Familia ☐ Grupo

Proveedor: use este formulario para documentar las necesidades que el sobreviviente más tiene en estos momentos. Este formulario se puede utilizar para comunicarse con las agencias de referidos para ayudar a promover la continuidad en el cuidado.

1. Marque los cuadros que correspondan a las dificultades que está experimentando el sobreviviente.

Comportamiento	Emocional	Físico	Cognoscitivo
☐ Desorientación extrema	☐ Reacciones de estrés agudas	☐ Dolores de cabeza	☐ Inhabilidad para aceptar/manejar la muerte de un ser querido
☐ Uso excesivo de drogas, alcohol o medicamentos recetados	☐ Reacciones de duelo agudas	☐ Dolores de estómago	☐ Sueños angustiantes o pesadillas
☐ Aislamiento/retraimiento	☐ Pena, llanto	☐ Dificultad para dormir	☐ Pensamientos o imágenes intrusivos
☐ Comportamiento de alto riesgo	☐ Irritabilidad, coraje	☐ Dificultad para comer	☐ Dificultad para concentrarse
☐ Comportamiento regresivo	☐ Se siente ansioso, temeroso	☐ Empeoramiento de condiciones de salud	☐ Dificultades para recordar
☐ Ansiedad por la separación	☐ Desesperación	☐ Cansancio/agotamiento	☐ Dificultad en la toma de decisiones
☐ Comportamiento violento	☐ Sentimientos de culpabilidad o vergüenza	☐ Agitación crónica	☐ Preocupación con la muerte/destrucción
☐ Afrontamiento desadaptativo	☐ Pérdida de sentimientos, desconexión	☐ Otro _____	☐ Otro _____
☐ Otro _____	☐ Otro _____		

Fuente: National Child Traumatic Stress Network (2006)

Nota: Se recomienda consultar el documento disponible en https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/pfa_sp.pdf si se desean imprimir los anexos directamente, los cuales se encuentran en el apéndice d y e.

2. Marque los cuadros que correspondan a las dificultades que está experimentando el sobreviviente.

- ☐ Trauma/problemas psicológicos/problemas de abuso de sustancias pasados o preexistentes
- ☐ Resultó lastimado por el desastre.
- ☐ Estuvo en riesgo de perder la vida durante el desastre
- ☐ Seres queridos perdidos o muertos
- ☐ Preocupaciones financieras
- ☐ Desplazado del hogar
- ☐ Arreglos de vivienda
- ☐ Pérdida del trabajo o escuela
- ☐ Asistencia en el rescate/recuperación
- ☐ Tiene discapacidades físicas/emocionales.
- ☐ Estabilización de medicamentos
- ☐ Preocupaciones con niño/adolescente
- ☐ Inquietudes espirituales
- ☐ Otro: _____

3. Por favor, anote cualquier otra información que pueda ser útil al hacer un referido.

4. Referido

- | | |
|--|--|
| ☐ Dentro del proyecto (especifique) | ☐ Tratamiento para el abuso de sustancias |
| ☐ Otras agencias de desastres | ☐ Otros servicios comunitarios |
| ☐ Servicios de salud mental profesionales | ☐ Representante religioso |
| ☐ Tratamiento médico | ☐ Otro: _____ |

5. ¿Aceptó el sobreviviente el referido?

- ☐ Si
- ☐ No

Fuente: National Child Traumatic Stress Network (2006)

ANEXO N° 5. HOJAS DE TRABAJO PERSONAS PROVEEDORAS DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS



Hojas de trabajo del proveedor

Componentes proporcionados de los Primeros Auxilios Psicológicos

Fecha: _____ Proveedor: _____

Ubicación: _____

Esta sesión se llevó a cabo con (marque todos los cuadros que correspondan):

☐ Niño ☐ Adolescente ☐ Adulto ☐ Familia ☐ Grupo

Haga una marca en el cuadro junto a cada componente de los Primeros Auxilios Psicológicos que usted proporcionó durante esta sesión.

Contacto y acercamiento

☐ Inició el contacto de manera apropiada. ☐ Preguntó por las necesidades inmediatas.

Seguridad y alivio

- | | |
|---|---|
| ☐ Tomó medidas para garantizar la seguridad física inmediata. | ☐ Dio información acerca del desastre/riesgos |
| ☐ Atendió el alivio físico. | ☐ Fomentó el acercamiento social. |
| ☐ Atendió a un niño separado de sus padres. | ☐ Protegió del trauma adicional. |
| ☐ Asistió con preocupaciones relacionadas con la desaparición de seres queridos. | ☐ Brindó asistencia después de la muerte de un ser querido. |
| ☐ Asistió a sobrevivientes con reacciones de duelo. | ☐ Ayudó a niños a expresarse acerca de la muerte. |
| ☐ Atendió asuntos espirituales relacionados con la muerte. | ☐ Brindó asistencia relacionada con el duelo traumático. |
| ☐ Proporcionó información acerca de funerales. | ☐ Ayudó al sobreviviente después de la identificación de un cadáver. |
| ☐ Ayudó a sobrevivientes en relación con la notificación de una muerte. | ☐ Ayudó a un niño después de la confirmación de una muerte. |

Estabilización

- | | |
|---|--|
| ☐ Ayudó con la estabilización. | ☐ Usó técnicas de enraizado (<i>grounding</i>). |
| ☐ Recopiló información para un referido a medicación para estabilizar. | |

Recopilación de información

- | | |
|---|--|
| ☐ Naturaleza y severidad de las experiencias en relación con el desastre | ☐ Muerte de un miembro de la familia o amigo |
| ☐ Preocupaciones ante la amenaza en curso | ☐ Preocupaciones acerca de la seguridad de seres queridos |

Recopilación de información – continuación

- | | |
|--|--|
| ☐ Enfermedad física/mental y medicamento(s) | ☐ Pérdidas relacionadas con el desastre |
| ☐ Culpabilidad o vergüenza extrema | ☐ Pensamientos relacionados con hacerse daño a sí mismo o a otros |
| ☐ Disponibilidad de apoyo social | ☐ Uso previo de alcohol o drogas |
| ☐ Historial de trauma o pérdida anterior | ☐ Preocupaciones acerca del impacto en el desarrollo |
| ☐ Otro _____ | |

Asistencia práctica

- | | |
|--|---|
| ☐ Ayudó a identificar las necesidades más inmediatas. | ☐ Ayudó a clarificar necesidades. |
| ☐ Ayudó a desarrollar un plan de acción. | ☐ Con acción ayudó a atender la necesidad. |

Conexión con apoyo social

- | | |
|--|---|
| ☐ Facilitó el acceso a personas de apoyo primario. | ☐ Habló sobre buscar y dar apoyo. |
| ☐ Modeló el comportamiento de apoyo. | ☐ Organizó actividades para los jóvenes. |
| ☐ Ayudó a resolver problemas para obtener/dar apoyo social. | |

Información acerca del manejo de adversidades

- | | |
|--|---|
| ☐ Proveyó información básica acerca de reacciones por estrés. | ☐ Entregó información básica acerca de las reacciones de manejo de adversidades. |
| ☐ Enseñó técnicas simples de relajación. | ☐ Ayudó con asuntos del manejo de adversidades de la familia. |
| ☐ Asistió con preocupaciones del desarrollo. | ☐ Asistió con el manejo del coraje. |
| ☐ Atendió emociones negativas (vergüenza/culpabilidad). | ☐ Ayudó con problemas del sueño. |
| ☐ Atendió problemas de abuso de sustancias. | |

Enlace con servicios de colaboración

- | | |
|--|-------|
| ☐ Proveyó enlace con servicios adicionales. | _____ |
| ☐ Promovió la continuación del cuidado. | _____ |
| ☐ Distribuyó folletos. | _____ |

Fuente: National Child Traumatic Stress Network (2006)



Cómo hacer conexiones con otros

Cómo buscar apoyo social

- El contacto con otros puede ayudar a reducir la sensación de angustia.
- Los niños y los adolescentes se pueden beneficiar al pasar un tiempo con compañeros de edad similar
- Las conexiones pueden ser con la familia, amigos u otros que están afrontando el mismo evento traumático.

Opciones de apoyo social

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| ▪ Cónyuge/compañero o padres | ▪ Representante religioso | ▪ Grupo de apoyo |
| ▪ Miembro de confianza de la familia | ▪ Doctor o enfermero | ▪ Compañero de trabajo/maestro/entrenador |
| ▪ Amigo cercano | ▪ Consejero de casos de crisis/ escolar u otro consejero | ▪ Mascota |

Lo que debe hacer:

- | | | |
|---|---|--|
| ▪ Decidir con cuidado con quién va a hablar | ▪ Comenzar hablando de cosas prácticas. | ▪ Preguntar a los demás si es un buen momento para hablar. |
| ▪ Decidir con tiempo de qué quiere hablar. | ▪ Hacer saber a los demás que usted necesita hablar o sólo pasar tiempo con ellos. | ▪ Decir a los demás que usted aprecia el que ellos le escuchen. |
| ▪ Escoger el momento y el lugar correcto. | ▪ Hablar de pensamientos y sentimientos dolorosos cuando esté preparado para hacerlo. | ▪ Decir a los demás qué necesita o cómo pueden ayudarlo—lo más que le ayudaría en ese momento. |

Lo que no debe hacer:

- | | |
|--|---|
| ▪ Mantenerse callado porque no quiere disgustar a los demás | ▪ Dar por hecho que los demás no quieren escucharlo |
| ▪ Mantenerse callado porque está preocupado de convertirse en una carga para los demás | ▪ Esperar hasta tener tanto estrés o fatiga que no podrá beneficiarse de la ayuda |

Formas de hacer la conexión

- | | |
|---|---|
| ▪ Llamar a amigos o familiares por teléfono | ▪ Participar en un grupo de apoyo |
| ▪ Aumentar el contacto con conocidos y amigos existentes | ▪ Participar en las actividades de recuperación de la comunidad o de la escuela |
| ▪ Renovar o comenzar la participación en un grupo religioso | |

Fuente: National Child Traumatic Stress Network (2006)

Cómo hacer conexiones con otro

Cómo prestar apoyo social

Usted puede ayudar a los miembros de las familias y a sus amigos a afrontar el desastre pasando tiempo con ellos y escuchándoles cuidadosamente. La mayoría de las personas se recuperan de mejor forma cuando desarrollan relaciones con otros que se preocupan por ellos. Algunas personas eligen no hablar de sus experiencias mientras que otros necesitan comunicarlas. El hablar sobre lo sucedido durante el desastre puede ayudar a algunos a que los eventos no resulten tan abrumadores. Otros se pueden sentir mejor, simplemente al pasar tiempo con personas cercanas o con aquellas que les permiten sentirse aceptados, sin la necesidad de tener que hablar sobre lo sucedido. A continuación encontrará información sobre cómo proveer apoyo social a otras personas.

Razones por las cuales una persona pudiera evitar el apoyo social

- No saber lo que necesita
- No querer ser una carga para otros
- Tratar de evitar pensar o tener sentimientos relacionados con el evento
- Sentirse avergonzado o “débil”
- Dudar de que sea provechoso o de que los otros entiendan
- Suponer que otros le juzgarán o se sentirán decepcionados
- Miedo a perder el control
- Tratar de buscar ayuda y sentir que no estaba disponible
- No saber dónde buscar ayuda

Formas adecuadas de brindar apoyo

- Demuestre interés, atención y que a usted le importa.
- Demuestre respeto por las reacciones de la persona y su forma de manejar la adversidad.
- Hable sobre las reacciones esperadas durante un desastre y la manera saludable de manejarlas.
- Encuentre un lugar donde hablar y tiempo sin interrupciones.
- Reconozca que este tipo de estrés puede tomar tiempo en disiparse.
- Demuestre confianza en que la persona es capaz de recuperarse.
- No juzgue o tenga expectativas.
- Ayude a promover ideas nuevas y positivas para el manejo de reacciones
- Ofrézcase para hablar o para compartir su tiempo cuantas veces sea necesario.

Fuente: National Child Traumatic Stress Network (2006)

Comportamientos que interfieren con la prestación de ayuda

- Apresurarse a decirle a alguien que estará bien; o que debe “superar ya la situación y seguir adelante”
- Actuar como si la persona es débil o está exagerando, pues no maneja la adversidad tan bien como usted
- Hablar sobre sus experiencias personales sin escuchar la historia de la otra persona
- Dar consejos sin escuchar las preocupaciones de las personas o sin preguntarles qué consideran conveniente para ellos
- Impedir que las personas hablen de lo que les molesta
- Decirles que tienen suerte pues pudo haber sido peor

Cuando su apoyo no es suficiente

- Comuníquese que los expertos señalan que la evitación y el retraimiento probablemente aumenten la angustia; y que el apoyo social ayuda en la recuperación.
- Anime a la persona a que hable con un consejero, un líder religioso o con un profesional médico y ofrézcale acompañarlo.
- Anime a la persona a participar en grupos de apoyo de personas que están atravesando por experiencias similares.
- Solicite la cooperación de otras personas de su círculo social de modo que todos participen en la tarea de apoyar a la persona.

Fuente: National Child Traumatic Stress Network (2006)

ANEXO N°7. LISTA DE RECURSOS LOCALES QUE PUEDE SER DE UTILIDAD

La lista debe contener los nombres de posibles instituciones, organizaciones y personas a los cuales se pueden referir a las personas según sus necesidades y contexto específico. Con los protocolos que se compartirán con usted, puede así visualizar con esta tabla las Instituciones u Organizaciones presentes para así no olvidar los recursos disponibles.

TIPO DE ACTOR SOCIAL	RECURSOS DISPONIBLES
Instituciones Públicas: INAMU, Ministerio de Salud, Dirección Regional de Ministerio de Educación Pública, Dirección General de Migración y Extranjería, PANI, Municipalidad, Comisión Nacional de Emergencias, etc.	
Policía y otras fuerzas del orden: Fuerza Pública, Policías Municipales, Policía de Migración, etc.	
Organizaciones de la sociedad civil: ONGs locales, Organizaciones religiosas, Guías y Scouts, colectivos, grupos de jóvenes, Comités Cantonales, etc.	
Organizaciones No Gubernamentales o Agencias de Cooperación Internacional: ACNUR, HIAS, RET, CENDEROS, Fundación Mujer, DNI, FUNPADEM, etc.	
Centros de Salud o Servicios Médicos: Cruz Roja, EBAIS, Clínicas, Hospitales y contactos de ATAPS	
Otras: Juntas de vecinos, empresas que comparten reclutamientos de personal, etc.	

Fuente: Elaboración Propia a partir de Experiencias en Comunidades.

La tabla anterior es un ejemplo de algunos tipos de Organizaciones o actores clave que se pueden mapear en una comunidad, sin embargo, por el carácter cambiante de cada una en las localidades, se recomienda cada año realizar un mapeo exhaustivo sobre los actores principales para el desarrollo de las actividades. Además, se recomienda generar alianzas o contacto con personas que pueden ser informantes claves sobre directrices nuevas que pueden ser de interés para el trabajo. Cada comunidad tendrá su contexto y actores más cercanos, por eso un catálogo de los mismos es de fácil acceso e incluso puede compartirse entre CREDES si fuera necesario.

ANEXO N°8. REACCIONES EMOCIONALES, COGNITIVAS, FÍSICAS E INTERPERSONALES COMUNES FRENTE A EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS RECIENTES

TABLA 1. REACCIONES EMOCIONALES, COGNITIVAS, FÍSICAS E INTERPERSONALES COMUNES FRENTE A EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS RECIENTES.

Reacciones emocionales	Reacciones físicas
• Estado de shock • Terror • Irritabilidad • Sentimiento de culpa (hacia sí mismo y hacia otros) • Rabia • Dolor o tristeza • Embotamiento emocional • Sentimientos de impotencia • Pérdida del disfrute derivado de actividades familiares • Dificultad para sentir alegría • Dificultad para experimentar sentimientos de amor y cariño por otros	• Fatiga, cansancio • Insomnio • Taquicardia o palpitaciones • Sobresaltos • Exaltación • Incremento de dolores físicos • Reducción de la respuesta inmune • Dolores de cabeza • Perturbaciones gastrointestinales • Reducción del apetito • Reducción del deseo sexual • Vulnerabilidad a la enfermedad
Reacciones cognitivas	Reacciones interpersonales
• Dificultades para concentrarse • Dificultades para tomar decisiones • Dificultades de memoria • Incredulidad • Confusión • Pesadillas • Autoestima decaída • Noción de autoeficacia disminuida • Pensamientos culposos • Pensamientos o recuerdos intrusivos sobre el trauma • Preocupación • Disociación (ej. visión túnel, estado crepuscular de conciencia, sensación de irrealidad, dificultades para recordar, sensación de separación del cuerpo, etc.)	• Incremento en conflictos interpersonales • Retraimiento social • Reducción en las relaciones íntimas • Alienación • Dificultades en el desempeño laboral o escolar • Reducción de la satisfacción • Desconfianza • Externalización de la culpa • Externalización de la vulnerabilidad • Sensación de abandono o rechazo • Sobreprotección
<i>Adaptado de Common Reactions After Trauma (2015), del National Center for PTSD, U.S Department of Veterans Affairs.</i>	

Fuente: Cortés y Figueroa (2015)

ANEXO N°9. PROPUESTA DE ABORDAJE DEL EJERCICIO PRÁCTICO.

- 1- **Se partirá del supuesto de que la persona si cuenta con las condiciones y capacitación para brindar la atención.**
- 2- **Los PAPs son aplicables en este caso específico.**
- 3- **Contacto, acercamiento y presentación:**
 - a. Primeramente, al haber acudido a las Instalaciones de Cruz Roja, seguramente se le habrá realizado una valoración física a Bianca con su consentimiento, por lo cual usted deberá pedir permiso a quien le atiende (si alguien más le está brindando la atención) y a Bianca para conversar.
 - b. Identifíquese, es fundamental compartir con Bianca, su nombre, institución que representa y las razones de su presencia en ese lugar. Esto creará un ambiente de seguridad, facilitando la aplicación de los PAS. Es indispensable portar alguna credencial, oficina o uniforme que le identifique para que la persona tenga un criterio mínimo para confiar en usted.
 - c. Explíquele que usted está haciéndose presente para ofrecer ayuda.
 - d. Nunca se deben pedir datos que no sean relevantes y siempre hacerle sentir escuchada.
 - e. Asienta con la cabeza, entienda los espacios de silencio, la pena o el llanto. No cuente la historia de otra persona o la suya, ya que no es recomendable, acá el centro es la situación de la persona.
 - f. Permanezca cerca de la persona, sentada a su lado y mirándole al rostro. Utilice técnica de “espejo”, adoptando posturalmente una actitud similar a la de la afectada, que le comunique que usted está en la misma “sintonía afectiva”.



4- **Seguridad:**

- a. Invite a Bianca a sentarse si no lo está o bien buscar una posición cómoda en el espacio que mejor le haga sentir en la instalación.
- b. Garantice la privacidad del espacio y confidencialidad de la información que ella vaya a compartir.
- c. Preste atención a la persona, modere el tono de voz (suavemente y calmado).

5- Alivio y Estabilización:

- a. Si cuenta con dichos recursos, ofrezca agua o algún bocadillo que sean adecuados para la persona (cerciórese primero sobre alergias o restricciones alimentarias), esto para que la persona pueda estabilizarse más fácilmente, ya que con su situación podría ser probable que tenga mucho tiempo sin comer o beber.
- b. Si Bianca sigue llorando y tiene algunos problemas para verse más calmada, así como respirar adecuadamente, es prudente a darle un pañuelo desechable, un vaso de agua y quizás también invitarla a realizar un ejercicio de respiración con usted para ayudarla a sentirse mejor.
- c. Puede indicarle con voz suave que reconoce que está pasando por una situación difícil y recordarle que ahora está en un espacio seguro. Puede proponerle hacer un ejercicio de respiración para que se sienta mejor y que puedan conversar para brindarle apoyo.
- d. Puede pedirle que intente copiar su ritmo de respiración, para ello se requiere seguir el siguiente ritmo: Inhalar en 4 tiempos (Contar lentamente del 1 al 4 a un ritmo similar al que tiene en el momento para que sea consciente de su ritmo actual), exhalar en 4 tiempos.
- e. Seguidamente se repite el ejercicio esta vez un poco más pausado. Recuerde felicitarla por lo bien que lo está haciendo y continuar algunas veces más para que normalice el ritmo de respiración. Es importante generar un espacio que le permita expresar sus emociones, por ejemplo, el llanto, y gradualmente calmarse para poder entablar una conversación clara.

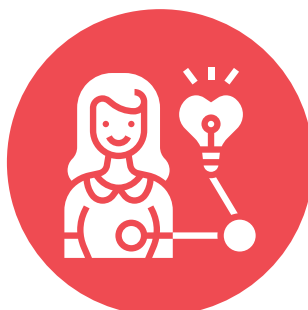


6- Recogida de Información (Needs and Worries):

- a. Cuando Bianca se ha logrado calmar, comente nuevamente quién es usted, qué está haciendo allí y su deseo de colaborar. Puede iniciar preguntándole por su nombre completo, lugar de procedencia, si viene en compañía de alguien y si quiere conversar con nosotros para saber qué puede hacer por ella, ya que usted está aquí para escucharle.
- b. Seguidamente, explique que requiere información básica para saber su estado de salud, ya que ha observado que aparenta estar en estado de embarazo. Sin embargo, igualmente para cualquier persona, aunque físicamente no se logre visualizar sus condiciones de salud, es importante a realizar las siguientes preguntas que permiten verificar si existe alguna condición que requiera de alguna acción inmediata: (recaltar que la información que le brinde será confidencial).
- c. ¿Padece de alguna (as) enfermedad(es) crónica (s) como diabetes, hipertensión, cáncer, VIH+, tiroides, enfermedad cardiovascular, renal, etc.? ¿Toma algún tratamiento? Si la respuesta es afirmativa: ¿Cuál es el grado de importancia del medi-

camento para mantener estable su condición de salud? ¿Cuánto tiempo lleva sin poder tomar ese medicamento?

- d. En el caso de la mujer embarazada: ¿Cuál es el periodo actual de gestación? ¿Fecha de la última atención prenatal? ¿Cuenta con alguna condición que represente su embarazo con mayor riesgo?



7- Asistencia Práctica:

- a. Al ser una mujer embarazada, es importante indicarle que puede estar más tranquila ya que en Costa Rica las mujeres en esta condición tienen acceso a la atención prenatal, así como verificar su estado actual para garantizar el bienestar de ella y el ser en gestación. Por este motivo, será necesario explicarle detalladamente al respecto, y de ser posible a cooperar para que se le pueda agendar una valoración de parte de la persona especialista del Centro de Salud más cercano.
- b. Puede indicarle que puede procurar coordinar que sea acompañada al centro de salud, si así lo desea, para que se le puedan hacer las pruebas necesarias para que esté más tranquila sobre su estado de salud actual. Además, el personal de Cruz Roja, compartirá la valoración que le hizo al llegar, por lo cual la llevarán directamente al Centro de Salud y en ese caso, usted podría acompañarla o comunicarse con antelación con el Centro de Salud para garantizar su acceso.
- c. Además, es útil a coordinar con el CEN-CINAI para valorar la opción de brindar alimentación básica en lo que resta del embarazo y garantizar lactancia del neonato en caso de ser necesario.
- d. Posteriormente, aclarados los aspectos de salud, pueden atenderse las preocupaciones de Bianca en el tema de seguridad. Para ello pregúntele cuáles son sus principales preocupaciones en este sentido, para poder evaluar los aspectos en los que se le puede cooperar para garantizar su bienestar integral.
- e. Durante dicho espacio, puede repetir detalles importantes del relato que ella haya señalado como importantes o preguntar algún detalle que sea de importancia para conocer su situación y encontrar cómo colaborar.
- f. Muéstrole y exprésele que reconoce su sufrimiento y que entiende que se puede estar sintiendo muy mal, puede utilizar la frase: “Esto debe ser difícil para usted...Es comprensible que se sienta así... muchas gracias por compartir esa información conmigo.
- g. (Si Bianca sigue muy angustiada y de nuevo vuelve a romper en llanto, ayúdele a calmarse como en los pasos anteriores. En este caso, puede utilizar otra técnica, por ejemplo la de enraizamiento o “grounding” para ayudarla a afrontar su estado emocional. (Ver el Anexo No. 3)

- h. Intente que Bianca pueda responder las siguientes interrogantes: “¿Qué es lo que le preocupa o necesita ahora de manera más inmediata? ¿puedo ayudarla a resolverlo?” esto es recomendable para poder identificar necesidades que no han sido externadas y entender cómo asesorar o referir a la persona de la manera más rápida posible con los servicios disponibles según su categoría migratoria.
- i. Posteriormente, haga una síntesis para saber si ella quiere agregar algo más o corregir algún aspecto que usted no haya comprendido correctamente sobre su relato. Seguidamente puede ayudarla a priorizar sus necesidades. Para esto puede pedirle que distinga entre lo que necesita solucionar inmediatamente y lo que puede esperar, diciendo: “... me doy cuenta de que son muchas las cosas que le preocupan. ¿Le parece si vamos paso a paso y nos enfocamos primero en lo más urgente? Así definimos qué podemos abordar inmediatamente y qué podría requerir de un plazo específico”.
- j. Seguidamente, por la información de este caso, puede identificar que Bianca califica como solicitante de refugio, por lo cual puede brindarle apoyo llamando al 1311 de migración desde un celular (ya sea Kolbi, Movistar o Claro) para tramitar su cita de formalización de trámite. Cuando le entregue su dato de confirmación de cita, puede explicarle que con este procedimiento cuenta temporalmente con una condición migratoria regular en el país, mientras se resuelve su solicitud, y que esto le confiere diversos derechos, incluyendo permanecer en el país sin riesgo de ser deportada. Es importante explicarle que debe guardar el comprobante de cita impreso y que no puede olvidar ni faltar la fecha de su cita, para que pueda seguir su proceso de formalización.



8- Conexión con Apoyos Sociales:

- a. Como la persona no cuenta con medios para subsistir, un apoyo importante puede ser a gestionar que se le reciba en un albergue comunitario facilitado por una congregación de hermanas de la comunidad.
- b. Debe realizarse además una referencia inmediata con ACNUR para que pueda recibir un apoyo de emergencia para que una vez vencido el periodo de estadía en el albergue pueda alquilar un apartamento y pueda contar con gastos básicos por tres meses.
- c. También es importante facilitarle una cita con el IMAS, para que se pueda evaluar su situación en dicha Institución.
- d. Por otro lado, si bien ella vino sola al país, usted se ha dado cuenta durante la conversación que su pareja también viene en camino, razón por la cual Bianca se encuentra muy preocupada. Bianca cuenta con el número de su pareja, “Santiago”, con quien se logra poner en contacto gracias al teléfono que le prestamos. Mediante este contacto, ella logra darse cuenta que él está por cruzar la frontera y llegaría probablemente al día siguiente a la comunidad. Con esta información, le solicitamos permiso a Bianca para poder brindarle ciertas pautas a su pareja, dentro de

ellas le recomendamos solicitar refugio en el puesto fronterizo ante un funcionario de migración y le mencionamos que seguiremos en línea hasta que se finalice el trámite, así mismo facilitamos nuestro correo electrónico para recibir la notificación de la solicitud. Logramos conseguir que se quede con miembros de una Iglesia en Peñas Blancas, quienes le traerán a la comunidad al día siguiente. Le indicamos a él y a las personas que le darán el transporte, la dirección exacta del albergue en donde se encuentra Bianca, ya que pudimos habilitar un espacio para el apenas se encuentre en la comunidad.

9- Información sobre el manejo de Adversidades:

Es relevante indicarle a Bianca que existen reacciones emocionales que son comunes en casos como el de ella, y que esto es algo que puede suceder a cualquier persona. Por lo tanto, puede recomendársele seguir usando los ejercicios que se le han enseñado como respiración, meditación o “grounding”. Además, es prudente indicarle que si condiciones como: los ataques de ansiedad, la angustia, el sentirse perseguida, los temblores, el insomnio, o las palpitaciones, entre otros síntomas, continúan, puede acudir al Centro de Salud y solicitar el servicio de psicología. De hecho, puede realizarse la gestión con el Centro de Salud de la localidad para solicitar de manera prioritaria una cita de atención en salud mental para las próximas semanas.



10- Conexión con servicios externos o de colaboración:

- Mediante diversas llamadas, usted ha conseguido que una organización les brinde un apoyo económico para los próximos 15 días, así como la incorporación a un grupo de apoyo terapéutico para personas en su misma condición.
- Además, la logró poner en coordinación con S.O.S Nicaragua, en donde podrá estar en coordinación directa con personas que fueron parte de los movimientos de protesta en su país de origen. Esto es un nuevo recurso sobre el cual Bianco no conocía y que la motiva, al saber que podrá contar con un espacio seguro para comunicarse con otras personas que tienen una visión afín..

11- Seguimiento:

- a. Al haber cubierto todos anteriores, y tras acompañar a Bianca al albergue, puede despedirse cordialmente de ella indicándole que está a su disposición si requiere alguna información adicional e indicándole todos los datos para que ella pueda comunicarse con usted...
- b. Puede recordarle que si olvida cualquier detalle, tiene problemas de acceso a derechos o bien aún tiene dudas, puede acudir al CREDES, y que de lo contrario, en una semana se estará poniendo en contacto para coordinar una cita de seguimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez, A. (2015). Dónde y Cómo se aplican los Primeros Auxilios Psicológicos. UTCCB Centro de crisis de la Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Barcelona. Repositorio Curso Virtual “Primeros Auxilios Psicológicos” Acceso en: <https://www.coursera.org/learn/PAS/home/welcome>

Campos, J. (2007). Pro Humanitas, Revista Especializada de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias. Recuperado de: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/concep.pdf>

Caplan, G. (1964). Principios de psiquiatría preventiva. Buenos Aires: Paidós. Recuperado de: <http://biblioteca.psi.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8596>

Cortés, P. y Figueroa, R. (2015). Manual ABCDE para la aplicación de Primeros Auxilios Psicológicos En crisis individuales y colectivas. Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Medicina, Departamento de Psiquiatría Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (cigiden). 1º edición. Recuperado de: https://www.preventionweb.net/files/59897_auxiliar.pdf

Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, Comisión Bipartita y Patronato Nacional de la Infancia (2012). PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD EXTRANJERAS NO ACOMPAÑADAS O SEPARADAS, FUERA DE SU PAÍS DE ORIGEN. <https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Ni%C3%B1ez/Protocolo%20Atenci%C3%B3n%20PME%20No%20Acompa%C3%B1ada%20o%20Separada.pdf>

DUPRET, Marie-Astrid y Nathalia Unda (2013). “Revictimización de niños y adolescentes tras denuncia de abuso sexual”. En: Universitas, XI (19), julio-diciembre, p. 101-128. Quito: Editorial Abya Yala/Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado de: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8576/1/Revictimizacion%20de%20ninos%20y%20adolescentes%20tras%20denuncias%20de%20abuso%20sexual.pdf>

Deza, S. (2007). Intervención en Crisis: Primeros Auxilios Psicológicos: Crisis Intervention: Psychological First Aid. Recuperado de: <http://revistas.unife.edu.pe/index.php/tematicapsicologica/article/view/896>

García, A. (2012). Introducción a los Métodos de Resolución Alternativa de Conflictos. Recuperado de: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8z9XeWjqOY4J:www.mjp.go.cr/Documento/DescargaDIR/1217+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=cr>

Guillén, S. Paniagua, F. y Arias, R. (2011). Manual de formación en negociación basada en intereses. Segunda Edición – San José, C.R: FUNPAPEM. PACT: USAID. Recuperado de: http://www.funpadem.org/app/webroot/files/publication/files/12_pub179_ibbtrainingmanualspanish.pdf

Guillén, S. y Paniagua, F. (2006). Guía para el manejo colaborativo de áreas protegidas. Colaboración y Negociación en el Comanejo. Recuperado de: https://www.academia.edu/1807149/Colaboraci%C3%B3n_y_Negociaci%C3%B3n_en_Comanejo_Gu%C3%ADa_para_el_Manejo_Colaborativo_de_%C3%81reas_Protegidas

González, L. (2017). Las paradojas de la migración, Estrategias psicocorporales para el abordaje del estrés postraumático. Estudio en una población de emigrantes uruguayos retornados. Ediciones Universitarias, Unidad de Comunicación de la Universidad de la República. Recuperado de: <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/17296/1/Gonzalez%20Boggio%2C%20Luis.pdf>

Hernández, M & Gutiérrez, E (2014) Manual Básico de Primeros Auxilios Psicológicos, Universidad de Guadalajara. Recuperado de: https://psicologosemergenciasbalears.files.wordpress.com/2016/08/manual-primeros-auxilios-psicolc3b3gicos_2014.pdf

Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. Geneva: IASC.

Organización Mundial de la Salud, War Trauma Foundation y Visión Mundial Internacional (2012). Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de campo. OMS: Ginebra. Recuperado de: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44837/9789243548203_spa.pdf;sequence=1

Organización Panamericana de la Salud (2006). Guía Práctica de Salud Mental en Desastres. Recuperado de: https://www.who.int/mental_health/paho_guia_practicade_salud_mental.pdf

Proyecto Esfera (2011). Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria Ginebra: El Proyecto Esfera. <http://www.sphereproject.org>

SLAIKEU, K. (1984). Intervención en crisis. Manual para práctica e investigación. Segunda Edición. Editorial Manual Moderno. Bogotá, Colombia. Recuperado de: https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/bienestar_estudiantil/guias/GBE.80.pdf

Save the Children (2013). Manual de capacitación sobre primeros auxilios psicológicos para profesionales de la niñez. Recuperado de: <https://psicologosemergenciasbalears.files.wordpress.com/2016/05/primeros-auxilios-psicolc3b3gicos-save-the-children.pdf>

Universidad Industrial de Santander (2014). GUÍA DE ATENCIÓN PACIENTE EN CRISIS EMOCIONAL – PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS. Recuperado de: https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/bienestar_estudiantil/guias/GBE.80.pdf

U.S Department of Veterans Affairs. PTSD: National Center for PTSD. Consultado el 26 de marzo de 2020 en: https://www.ptsd.va.gov/spanish/common_reactions_sp.asp

Villalobos, J. (2011). “Manual de Intervención en Crisis para la Atención de población Colombiana con Necesidad de Protección Internacional en las oficinas del Servicio Jesuita a refugiados y Migrantes – Ecuador”. Recuperado de: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1339/14/UPS-QT00287.pdf>

Simon V. (2006). Mindfulness y neurobiología. Revista de Psicoterapia. 2006; 17 (66-67):5-30. Recuperado de: https://www.academia.edu/8485676/Revista_de_Psicoterapia_66_67



INFORMACION DE CONTACTO

 /FUNPADEM |  @FUNPADEM

 info@FUNPADEM.org

funpadem.org